Serie de documentos técnicos en el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar del departamento de Boyacá

Pautas de cuidado basadas en la evidencia para familias con recién nacidos y mujeres en posparto en el entorno hogar

Gobernación de Boyacá | Salud

Serie de documentos técnicos en el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar del departamento de Boyacá

Gloria Yaneth Manrique Abril

Secretaria de salud

Candy Samanta Rodríguez Castillo

Directora de Promoción y Prevención

Martín Orlando Barrera Cobos

Profesional Universitario

Secretaría de Salud de Boyacá

Blanca Nubia Vásquez

Profesional Universitario

Secretaría de Salud de Boyacá

Serie de documentos técnicos en el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar del departamento de Boyacá

Grupo Desarrollador

Lorena Mesa Melgarejo

Enfermera, Magister en Salud Pública, Máster en Economía de la Salud y Doctora en Salud Pública. Secretaria de Salud de Boyacá

Diana María Igua Ropero

Médico cirujano. Especialista Medicina Familiar. Experto en Inteligencia Artificial para profesionales innovadores. Universidad de la Sabana. Docente posgrado Medicina Familiar. UPTC.

Sara Paola Carrillo Jiménez

Medico. Ginecoobstetra. Magister en Salud Publica. Asesora del programa de salud sexual y reproductiva, SESALUB

Astrid Paola López

Enfermera. Magister en Salud Pública. Profesional de apoyo. Equipos profesionales de apoyo del programa de salud sexual y reproductiva

Yenny Paola Ávila Lizarazo

Enfermera. Magister en Salud Pública. Profesional de apoyo. Equipos profesionales de apoyo del programa de salud sexual y reproductiva

Expertas participantes

Briggitte Migdolia Prieto Bocanegra

Enfermera. Magíster en Enfermería con énfasis en Cuidado materno-perinatal. Docente Programa de enfermería. UPTC

Luisa Fernanda Vargas Nossa

Enfermera. Mg en Desarrollo Infantil. Especialista en Cuidado Crítico Pediátrico. Directora PROFAMILIA Tunja

Constanza Marcela García

Bacterióloga. Epidemióloga. Master en Salud Publica. Referente. Profesional Universitario. Programa de salud sexual y reproductiva. Secretaria de Salud de Boyacá

Declaración de conflictos de intereses:

Las personas que participaron en la elaboración, revisión y validación de las presentes Pautas de cuidado basadas en la evidencia fueron invitadas a declarar sus intereses financieros, profesionales, académicos, institucionales y personales que pudieran influir, o percibirse como susceptibles de influir, en el desarrollo de los contenidos y la formulación de las recomendaciones. No se identificaron conflictos de intereses que comprometieran la independencia técnica del proceso de elaboración de este documento.

Declaración de uso de Inteligencia Artificial:

La herramienta Claude de Anthropic fue utilizada en el presente documento para el proceso de extracción de datos de los textos completos seleccionados en las matrices de síntesis de la información. Su utilización fue complementaria al trabajo del equipo responsable y no sustituyó los procedimientos de búsqueda, selección, análisis crítico e interpretación de la evidencia científica, ni los procesos de deliberación y formulación de las pautas de cuidado. La responsabilidad por la rigurosidad metodológica, la pertinencia de las recomendaciones, la integridad de la información y el contenido final del documento corresponde exclusivamente al equipo humano responsable de su elaboración.

Serie de documentos técnicos en el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar del departamento de Boyacá

Contenido

1. Introducción 7
2. Objetivos 8
   2.1 General 8
   2.2 Específicos 8
3. Alcance 8
   Población objetivo 8
   Usuarios 9
   Contexto 9
   Aspectos abordados 9
   Aspectos no abordados 9
4. Contexto territorial de la condición de salud 9
   4.1 Dimensión epidemiológica 9
   4.2 Dimensión clínica 10
   4.3 Dimensión de contexto, acceso y continuidad del cuidado 11
5. Marco normativo 12
6. Preguntas orientadoras 14
7. Metodología 14
   7.1 Priorización de temas 14
   7.2 Construcción y validación del alcance y preguntas orientadoras. 15
   7.3 Búsqueda y selección de la evidencia. 15
   7.4 Síntesis de evidencia y formulación de pautas basadas en evidencia. 17
   7.5 Consenso informal, adaptación al contexto y reglas de decisión. 17
8. Resultados: Síntesis narrativa de la evidencia 17
   8.1 Pregunta 1. 17
   8.2 Pregunta 2. 28
   8.3 Pregunta 3. 38
   8.4 Pregunta 4. 54

9. Pautas de cuidado basadas en la evidencia para familias con recién nacidos y mujeres en posparto en el entorno hogar. 64
9.1 Pautas pregunta 1. Valoración integral y estratificación del riesgo 64
9.2 Pautas pregunta 2. Intervenciones familiares estructuradas 72
9.3 Pautas pregunta 3. Criterios de alarma y activación de rutas .. 77
9.4 Pautas pregunta 4. Agencia de cuidado familiar 82
10. Referencias 87
11. Anexos 89
11.1 Anexo 1. Ecuaciones de búsqueda 89

1. Introducción

En Boyacá, el cuidado del recién nacido y de las mujeres en posparto constituye un foco prioritario por su potencial de desenlaces prevenibles y por las inequidades territoriales que persisten en el acceso oportuno a atención y seguimiento. Aunque el departamento ha mantenido, en términos generales, indicadores materno-infantiles por debajo del promedio nacional en años recientes, en 2021 la razón de mortalidad materna fue de 32,44 muertes por 100.000 nacidos vivos y la tasa de mortalidad neonatal fue de 4,06 por 1.000 nacidos vivos, cifras que siguen representando un riesgo evitable y sensible a la calidad y oportunidad del cuidado perinatal(1) .

El problema adquiere mayor relevancia cuando se analizan brechas por territorio. En 2021, la razón de mortalidad materna fue más alta en el área rural dispersa (42,63 por 100.000 nacidos vivos) que en cabecera municipal (28,81), y la mortalidad neonatal también muestra diferencias por área de residencia, con tasas más elevadas en ruralidad frente a cabecera(1) . Estas desigualdades son consistentes con la lectura del ASIS 2024, que sugiere inequidades para indicadores materno-infantiles a favor de poblaciones más privilegiadas cuando se analiza por estratificación socioeconómica (2). Así, es posible considerar que el posparto y el periodo neonatal siguen siendo ventanas críticas donde el riesgo se concentra y donde la oportunidad de detectar signos de alarma, apoyar lactancia, prevenir complicaciones y asegurar controles marca diferencias en resultados.

Aun cuando Boyacá presenta una tendencia de descenso en indicadores de fecundidad, el volumen de nacimientos y la complejidad del cuidado temprano demandan una respuesta estandarizada y proactiva. El Plan Territorial de Salud reporta que los nacimientos han venido disminuyendo (por ejemplo, de 12.625 en 2021 a 11.585 en 2023p) y que la tasa global de fecundidad continúa en descenso, con cambios también en embarazo adolescente. Esta transición no reduce la importancia del tema; por el contrario, plantea el reto de garantizar calidad y continuidad del cuidado materno-neonatal en poblaciones más pequeñas y dispersas, evitando que las barreras geográficas o sociales se traduzcan en retrasos diagnósticos o en eventos prevenibles.

En el marco del Plan Integral de Cuidado Familiar (PICF), una herramienta basada en evidencia para “Cuidados en el hogar para familias con recién nacidos y mujeres en posparto” se justifica para disminuir la variabilidad en la práctica, fortalecer la agencia de cuidado familiar y asegurar continuidad del seguimiento en el entorno hogar, especialmente en los

primeros días y semanas posteriores al nacimiento. La evidencia internacional respalda explícitamente las visitas en el hogar en la primera semana para el cuidado de la madre y el recién nacido, así como contactos posnatales adicionales (por ejemplo, día 3; entre días 7–14; y a las 6 semanas) para detectar complicaciones y promover prácticas protectoras. Con base en ello, se orientará qué evaluar, cómo priorizar riesgo, qué intervenciones familiares son esenciales (lactancia, autocuidado posparto, señales de alarma maternas y neonatales, y acceso oportuno a controles y vacunación) y cuándo activar rutas de remisión, integrando la respuesta clínica con los determinantes y realidades del territorio.

2. Objetivos

2.1 General

Desarrollar pautas de cuidado basadas en la evidencia para orientar las acciones de cuidado del equipo de salud en el entorno hogar para el acompañamiento a la familia con recién nacido.

2.2 Específicos

- ✓ Estandarizar la valoración integral de la familia-recién nacido en el entorno hogar para identificar riesgos clínicos y familiares, y convertirlos en compromisos de cuidado.
- ✓ Definir intervenciones basadas en evidencia para fortalecer la agencia de cuidado familiar (lactancia, autocuidado posparto, cuidado seguro del RN, apoyo emocional y corresponsabilidad), incorporando educación dialógica y redes de apoyo.
- ✓ Establecer criterios de alarma y coordinación con redes que protejan la seguridad de la familia-RN y anticipen riesgos, articulando con la ruta materno-perinatal.
- ✓ Proponer con base en la evidencia disponible un esquema de acompañamiento al cumplimiento de compromisos en el hogar.

3. Alcance

Población objetivo

Familias con recién nacido (término o pretérmino dado de alta), padre y madre en posparto.

Usuarios

Equipos básicos de salud del nivel primario de atención que realizan visitan en el hogar.

Contexto

Entorno hogar (visita PICF) para educación, detección temprana de signos de alarma, apoyo a lactancia, cuidado del cordón/termorregulación, salud mental posparto, planificación, y activación de rutas.

Aspectos abordados

- Tamizaje de riesgos maternos (hemorragia, infección, HTA posparto, salud mental) y neonatales (ictericia, fiebre, dificultad respiratoria, pobre succión, pérdida de peso).
- Prácticas protectoras en hogar y verificación de acceso a controles y vacunación.
- Plan familiar de apoyo: roles, descanso, señales de alarma y rutas.

Aspectos no abordados

Manejo hospitalario de emergencia obstétrica/neonatal o complicaciones que requieren atención especializada; no reemplaza rutas vigentes.

4. Contexto territorial de la condición de salud

4.1 Dimensión epidemiológica

En Boyacá, los desenlaces materno-perinatales siguen siendo eventos trazadores y sensibles a desigualdades territoriales y sociales. El ASIS 2023 muestra que en 2021 la razón de mortalidad materna total fue 32,44 por 100.000 nacidos vivos, con brechas por área de residencia: 42,63 en área rural dispersa frente a 28,81 en cabecera municipal(1) . Para el mismo año, la tasa de mortalidad neonatal fue mayor en ruralidad (5,54 por 1.000 nacidos vivos) que en cabecera (3,31 por 1.000), mostrando inequidades persistentes en el periodo de mayor vulnerabilidad.

El ASIS 2024 confirma que en 2022 persisten diferencias por área: la razón de mortalidad materna fue 40,06 en rural dispersa y 56,79 en urbano/cabecera, y la mortalidad neonatal fue 5,21 en rural y 4,26 en urbano; adicionalmente, este mismo análisis reporta análisis de desigualdades con índice de concentración (estratificado por NBI), donde los indicadores de mortalidad materna, neonatal e infantil muestran valores negativos, sugiriendo desigualdad a favor de los más privilegiados (2) Desde la perspectiva de causa básica, el ASIS 2024 evidencia carga por afecciones originadas en el periodo perinatal (663 muertes entre 2012–2021, 61,3% en menores de un año) y destaca subcausas relevantes en el recién nacido, como trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, sepsis bacteriana del recién nacido, retardo del crecimiento fetal/bajo peso y feto-recién nacido afectado por complicaciones obstétricas/traumatismo del nacimiento. Este perfil refuerza que, además de la atención intrahospitalaria, el cuidado temprano en el entorno hogar (detección de signos de alarma, apoyo a lactancia, termorregulación, higiene, acceso oportuno a controles) es decisivo para prevenir complicaciones y muertes evitables (2) .

4.2 Dimensión clínica

Es útil explicitar definiciones clínicas que guían la priorización y el seguimiento. La OMS define la mortalidad neonatal como la muerte ocurrida en los primeros 28 días de vida (0–27 días) por cada 1.000 nacidos vivos. El periodo posnatal/posparto es una ventana de alto riesgo para madre y recién nacido en la que se concentran complicaciones prevenibles (hemorragia, infección/sepsis, hipertensión posparto, depresión posparto; e ictericia, dificultad respiratoria, fiebre, mala succión, deshidratación o pérdida de peso en el recién nacido), y donde el reconocimiento precoz y la remisión oportuna cambian el pronóstico. En coherencia con esto, las recomendaciones de la OMS indican la necesidad de contactos posnatales estructurados y resaltan que, además del contacto inmediato tras el parto, se recomiendan al menos tres contactos adicionales para todas las madres y recién nacidos: día 3 (48–72 horas), entre días 7–14 y a las 6 semanas; estos contactos pueden incluir visitas en el hogar por personal entrenado o agentes comunitarios supervisados.

La evidencia científica apoya el valor de la atención en el hogar en contextos con barreras de acceso: un metaanálisis clásico encontró que los recién nacidos que recibieron una visita posnatal en el hogar dentro de los 28 días tuvieron menor mortalidad neonatal que quienes no recibieron visitas, aunque con variación por contexto y sin poder definir

un "número óptimo" universal de visitas. En un departamento con heterogeneidad territorial, esta evidencia sustenta que la estandarización de cuidados en el entorno hogar debe enfocarse en qué evaluar, qué enseñar, qué verificar (lactancia, signos de alarma, acceso a controles) y cuándo remitir, más que en "copiar" un calendario rígido.

4.3 Dimensión de contexto, acceso y continuidad del cuidado

En Boyacá, la problemática materno-perinatal se asocia a debilidades de gobernanza, fragmentación de la atención y barreras de acceso, particularmente en zonas rurales y dispersas. El ASIS 2023 identifica insuficiente implementación/adherencia a actividades de la Ruta Materno-Perinatal y describe factores como bajo acceso a servicios preconcepcionales, atención fraccionada (por ejemplo, entrega inoportuna de medicamentos/dispositivos), insuficiencia o baja capacitación de talento humano, infraestructura limitada y un sistema de referencia y contrarreferencia débil (1) . También señala barreras por dispersión geográfica, mal estado de vías, bajos ingresos para desplazamiento y desarticulación de sistemas de información, lo que dificulta la priorización oportuna de gestantes y la respuesta en emergencias.

En respuesta, los ASIS destacan la implementación de estrategias para reducción de mortalidad materna, con participación intersectorial y comunitaria orientada a educación, detección temprana de complicaciones y acceso oportuno durante embarazo, parto y posparto. Por su parte, en SIBCOM (PICF), aparecen señales operativas directas para orientar una herramienta de pautas de cuidados en el entorno hogar. El informe de julio muestra indicadores de gestación, parto y posparto con hallazgos de riesgo: altos porcentajes de gestantes <18 o >35 años, limitaciones sin control en el primer trimestre, con un valor de 45% en Subred 9) y proporciones relevantes de partos extrahospitalarios (superiores al 40% en algunas subredes, con un dato crítico en Subred 10 en junio) (3) . En el mismo informe, se observan desigualdades en prácticas protectoras: la lactancia materna exclusiva alcanza 100% en algunas subredes, mientras que en otras se ubica alrededor de 15–20%, lo cual sugiere brechas en educación, apoyo y condiciones del hogar para sostener la lactancia.

En términos generales, Boyacá presenta una carga materno-perinatal con brechas por área y desigualdades socioeconómicas, junto con señales

operativas desde SIBACOM de riesgo obstétrico, control prenatal tardío, parto extrahospitalario y desigualdad en lactancia.

5. Marco normativo

El desarrollo del presente documento tiene en consideración el marco normativo nacional y territorial vigente y en particular las siguientes normas aplicables:

Tabla 1. Normativa aplicable a la herramienta

Norma	Aspecto aplicable al lineamiento
Ley 1098 de 2006. Código de la Infancia y la Adolescencia	Establece la protección integral y la prevalencia de los derechos de niñas y niños. Reconoce el derecho a la salud integral y define como derechos impostergables de la primera infancia la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación y la protección frente a riesgos. Es especialmente pertinente para los componentes de protección, negligencia, violencia, acceso oportuno a servicios y activación de rutas ante riesgos para el recién nacido.
Ordenanza 023 de 2010 del departamento de Boyacá	Adopta el Modelo de Atención Primaria en Salud con Enfoque Familiar como política pública en salud del departamento. Sustenta territorialmente el abordaje familiar, la integralidad, continuidad, articulación entre aseguramiento, prestación y salud pública, así como la acción intersectorial que fundamenta el PICF.
Ley 1438 de 2011	Fortalece el SGSSS mediante la estrategia de Atención Primaria en Salud. Define la APS a partir de tres componentes integrados: servicios de salud, acción intersectorial/transectorial y participación social, comunitaria y ciudadana. Sustenta el abordaje territorial, familiar, integral e integrado del PICF.
Ley Estatutaria 1751 de 2015	Regula el derecho fundamental a la salud y establece los principios de accesibilidad, oportunidad, continuidad, equidad, integralidad, calidad y prevalencia de los derechos de niñas y niños. Es fundamento para la identificación de barreras, continuidad de las rutas y atención sin dilaciones ante riesgos maternos o neonatales.
Ley 1804 de 2016. Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia "De Cero a Siempre"	Establece el marco de atención integral a la primera infancia y reconoce a niñas y niños como sujetos de derechos desde el nacimiento. Sustenta la articulación intersectorial, el enfoque de desarrollo integral y la responsabilidad conjunta de familia, sociedad y Estado durante la primera infancia.
Resolución 2465 de 2016	Adopta los indicadores antropométricos, patrones de referencia y puntos de corte para la clasificación antropométrica del estado nutricional, incluidos niñas y niños menores de 18 años. Es pertinente para estandarizar la interpretación del peso y

	otros datos antropométricos utilizados en el seguimiento del recién nacido.
Resolución 3280 de 2018, modificada por la Resolución 276 de 2019	Constituye la principal norma técnica nacional para este lineamiento. Adopta la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal. Define las atenciones del puerperio, cuidado y seguimiento del recién nacido, lactancia, educación para la salud, valoración de riesgos, atención a las familias, controles, tamizajes y mecanismos de continuidad. La Resolución 276 de 2019 introdujo modificaciones a su operación y anexos técnicos.
Ley 2244 de 2022. Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado	Debe incorporarse. Reconoce expresamente los derechos de la mujer durante embarazo, parto y posparto, así como los derechos del recién nacido. Incluye autonomía, información, acompañamiento, trato digno, enfoque diferencial, contacto piel a piel, inicio del amamantamiento y cuidados del recién nacido basados en evidencia. Es particularmente relevante para los lineamientos de participación familiar, autonomía, cuidado respetuoso y posparto.
Ley 2297 de 2023	Establece medidas en beneficio de la autonomía de las personas con discapacidad y de sus cuidadores o asistentes personales, incluyendo formación y atención en salud. Su aplicación en este lineamiento es condicionada, por ejemplo, cuando la mujer, el recién nacido u otro integrante dependiente de la familia presenta discapacidad y existen necesidades específicas de cuidado o apoyo. No la ubicaría como norma nuclear del posparto o cuidado neonatal.
Ley 2458 de 2025	Debe incorporarse por su alta pertinencia. Establece medidas para fortalecer la comunidad lactante y la promoción y apoyo de la lactancia materna. Define la comunidad lactante incluyendo madre, bebé, padre, acompañantes, familiares, profesionales y redes de apoyo, y vincula expresamente su implementación con EPS, IPS y actores del parto y puerperio. Refuerza el enfoque familiar y comunitario que estamos utilizando en el PICF.
Resolución 1597 de 2025	Establece disposiciones para la Gestión Territorial Integral de la Salud Pública, incluida la Gestión en Salud Pública y el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, en el marco del PDSP y la estrategia APS. Sustenta el cuidado integral, la gestión territorial, la acción intersectorial, la participación social y comunitaria y la articulación de las intervenciones individuales, familiares y colectivas. Derogó, con una excepción específica para población indígena, las Resoluciones 518 de 2015 y 295 de 2023.

Fuente: elaboración propia

6. Preguntas orientadoras

- En familias con recién nacidos en el entorno hogar, ¿qué estrategias, instrumentos o criterios de valoración integral utilizados por los equipos de salud permiten identificar y estratificar el riesgo materno, neonatal, familiar, psicosocial y del entorno, para orientar la priorización del seguimiento, las acciones de cuidado y la activación oportuna de rutas de atención?
- En familias con recién nacidos y mujeres en posparto atendidas en el entorno hogar, ¿qué intervenciones familiares estructuradas son efectivas y factibles para mejorar resultados de salud neonatal, materna-posparto y de cuidado familiar, y qué componentes deben estandarizarse en el PICF?
- En recién nacidos, mujeres en posparto y familias atendidas en el entorno hogar, ¿qué signos de alarma y criterios de riesgo clínico, psicosocial, familiar o del entorno deben activar rutas de atención, remisión, seguimiento prioritario o respuesta intersectorial para garantizar oportunidad y continuidad del cuidado en el nivel primario?
- En familias con recién nacidos y mujeres en posparto atendidas mediante visitas sucesivas en el entorno hogar, ¿qué estrategias educativas, participativas y de seguimiento favorecen la agencia de cuidado familiar, y cómo debe monitorearse su implementación durante el ciclo de cuidado del PICF?

7. Metodología

El desarrollo de esta herramienta se basa en el Manual para el desarrollo de lineamientos técnicos basados en evidencia del IETS (primera edición, 2024) y en el objetivo de consolidar y difundir acciones/indicaciones basadas en la mejor evidencia disponible e integrando experiencia experta y contexto territorial. Así, la metodología se organizó en cuatro momentos: 1. Priorización de temáticas; 2. validación de preguntas con equipo AT-PIC y referentes; 3. búsqueda y selección sistemática de evidencia y síntesis, y 4. construcción de pautas/lineamientos con consenso informal.

7.1 Priorización de temas

El proceso de priorización de temáticas para desarrollar cinco herramientas basadas en evidencia en el marco del PICF inició con una

identificación preliminar de problemáticas mediante triangulación de fuentes (seguimiento PICF, cruce con núcleos/respuestas del Plan Territorial de Salud y ASIS), delimitando desde el inicio temas con alta posibilidad de intervención directa por los equipos básicos (acciones clínicas, seguimiento familiar, educación, detección temprana y articulación con RIAS) y excluyendo determinantes estructurales cuyo abordaje principal no es sanitario. Posteriormente, se aplicó una priorización multicriterio con cinco criterios explícitos (magnitud, severidad, inequidad, factibilidad y alineación), con ponderaciones sugeridas (25%, 20%, 20%, 25% y 10%, respectivamente) y un esquema de votación 1–5 con reglas de inclusión/exclusión por acuerdo ≥80%, utilizando una técnica tipo Delphi con calificación ciega por expertas/os.

La priorización se realizó en dos rondas con dos grupos: primero el equipo de Asistencia Técnica del PIC (ronda 1) y luego el equipo de Promoción y Prevención (ronda 2), incorporando además temáticas nuevas sugeridas al final del cuestionario para ser consideradas en la segunda ronda. Finalmente, tras comparar resultados de la segunda ronda, se definieron las cinco temáticas seleccionadas para la vigencia: (i) riesgo cardiovascular familiar, (ii) consumo de riesgo y problemático de alcohol, (iii) salud del cuidador en hogares con dependencia/cronicidad, (iv) valoración y cuidado integral de la persona mayor (vejez) y (v) cuidados en el hogar para familias con recién nacidos y mujeres en posparto.

7.2 Construcción y validación del alcance y preguntas orientadoras.

A partir de la triangulación de fuentes sobre los aspectos epidemiológicos, clínicos y de interacción con algunos equipos de salud, se construyeron las preguntas orientadoras, las cuales se socializaron y validación con el equipo y referentes por medio de sesiones deliberativas. Este proceso sigue el modelo de lineamientos que contempla reuniones para discutir, ajustar y consensuar alcance y preguntas.

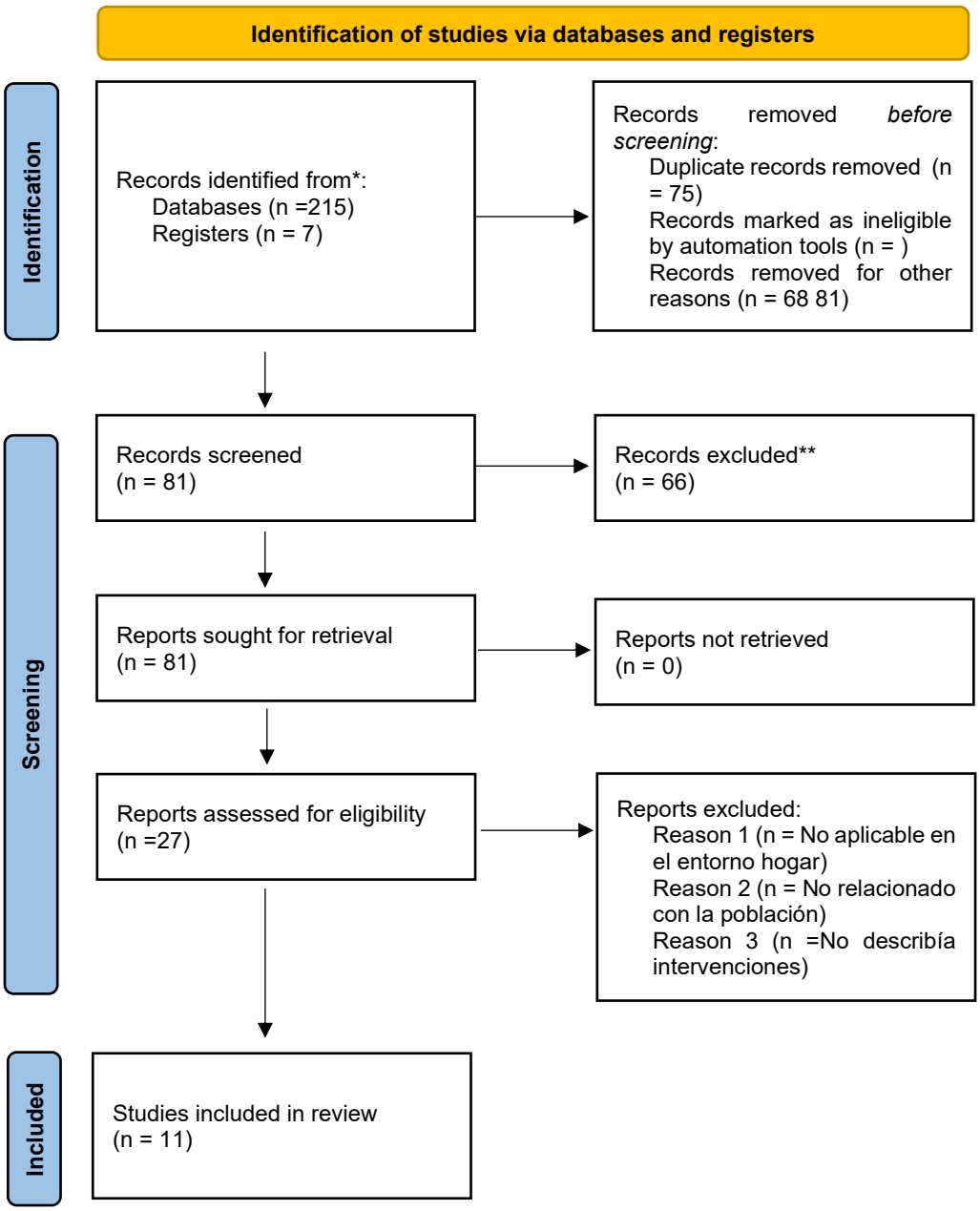
7.3 Búsqueda y selección de la evidencia.

Para responder a cada pregunta, se realizó una búsqueda sistemática estructurando ecuaciones de búsqueda a partir de términos indexados. Se realizó la búsqueda en las siguientes bases de datos: MEDLINE,

Cochrane y LILACS, complementada con literatura gris mediante Google Académico (Anexo 1).

La estrategia incluyó (i) una búsqueda para identificar Guías de Práctica Clínica (GPC) recientes y (ii) una búsqueda para identificar revisiones sistemáticas, con búsquedas independientes por pregunta cuando fue necesario. Los criterios de inclusión fueron: evidencia aplicable al entorno hogar, acorde con la población objeto, revisiones sistemáticas de literatura, guías de práctica clínica, consensos basados en la evidencia, publicaciones en inglés o español, sin límite de año. Las RSL se verificaron con la lista de chequeo AMSTAR; AGREE para el caso de las GPC, y ACCORD para el caso de los consensos.

El siguiente esquema presenta el PRISMA del proceso de selección:



7.4 Síntesis de evidencia y formulación de pautas basadas en evidencia.

La evidencia incluida se resumió en aspectos clave para las intervenciones recomendadas en el entorno hogar para cada pregunta (beneficios/daños, desempeño de instrumentos de estratificación, factibilidad, recursos, equidad, aceptabilidad) y privilegiando la síntesis narrativa. Con base en esto y en la experiencia del equipo clínico y territorial, se elaboraron pautas preliminares que posteriormente se sometieron a discusión y consenso por parte del grupo de referentes de la secretaria de salud del departamento.

7.5 Consenso informal, adaptación al contexto y reglas de decisión.

Las pautas preliminares se discutieron rondas sincrónicas y asincrónicas con cuatro tipos de actores: 1. Expertas familiaristas vinculadas al proceso de implementación de las unidades de análisis del PIC. 2. Referentes de la secretaria de salud de Boyacá, 3. Equipos territoriales, buscando asegurar pertinencia territorial y aplicabilidad en el entorno hogar y 4. Equipo docente de la especialidad de medicina familiar de la UPTC. La aprobación de cada pauta se realizó mediante deliberación y acuerdo informal.

8. Resultados: Síntesis narrativa de la evidencia

8.1 Pregunta 1.

En familias con recién nacidos en el entorno hogar, ¿qué estrategias, instrumentos o criterios de valoración integral utilizados por los equipos de salud permiten identificar y estratificar el riesgo materno, neonatal, familiar, psicosocial y del entorno, para orientar la priorización del seguimiento, las acciones de cuidado y la activación oportuna de rutas de atención?

- ***Valoración integral y estratificación del riesgo de las familias con recién nacidos en el entorno hogar.***

La evidencia revisada no identificó un instrumento único, validado y suficientemente integral que permita clasificar mediante una puntuación

global el riesgo materno, neonatal, familiar, psicosocial y ambiental de las familias con recién nacidos. Las guías y documentos seleccionados convergen, en cambio, en un modelo de valoración multidimensional, estructurada y repetida de la díada mujer–recién nacido dentro de su contexto familiar y domiciliario. Tampoco se identificaron instrumentos relacionados con el rol paterno y la valoración de su proceso o adaptabilidad en esta circunstancia de la familia. En la valoración multidimensional, la estratificación del riesgo se construye integrando los antecedentes maternos y perinatales, la valoración clínica de la mujer y del recién nacido, la alimentación, la salud mental, las capacidades de los cuidadores, la dinámica familiar, las condiciones del hogar, las redes de apoyo y las posibilidades reales de acceder a los servicios de salud.

El documento de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, concluye que la visita domiciliaria es fundamental en el proceso de valoración e identificación de riesgos, pues ésta aporta información que difícilmente puede obtenerse mediante una consulta institucional. Además de permitir la valoración presencial de la mujer y del recién, facilita observar directamente el entorno, la interacción entre la madre, el bebé y los demás cuidadores, las prácticas cotidianas de alimentación e higiene, el espacio destinado al sueño, la distribución de responsabilidades y las barreras materiales o geográficas para buscar atención. La OMS reconoce que la visita al hogar requiere tiempo adicional al destinado para las consultas institucionales para efectuar una valoración general del ambiente y de la interacción madre–recién nacido, y recomienda que los equipos dispongan de registros domiciliarios, formatos de remisión, materiales de consejería y equipos portátiles, como balanza, termómetro y reloj o temporizador(4).

La valoración domiciliaria debe entenderse como complementaria y articulada con los controles clínicos de la mujer en posparto y del recién nacido, y no como su sustitución. La Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal establece que el control del recién nacido debe garantizarse durante los primeros cinco días después del egreso, idealmente entre el tercer y el quinto día, con una duración y profundidad diferenciadas cuando existan antecedentes prenatales, perinatales o posnatales de mayor riesgo(5). La visita domiciliaria se indica cuando se requieren medidas adicionales para mejorar la lactancia, vigilar el cuidado neonatal, fortalecer el reconocimiento de signos de peligro tanto en la mujer como en el recién nacido, verificar el plan de cuidado de recién nacidos con complicaciones o riesgos y hacer seguimiento a la adherencia al tratamiento en casos de depresión posparto. El seguimiento telefónico puede complementar estas acciones, pero no reemplaza el control presencial ni la visita domiciliaria cuando ha sido indicada(4).

- ***Temporalidad y reevaluación del riesgo.***

La evidencia respalda una valoración longitudinal, dado que el riesgo puede cambiar rápidamente durante los primeros días y semanas posteriores al nacimiento. La OMS recomienda un mínimo de cuatro contactos posnatales: durante las primeras 24 horas, entre las 48 y 72 horas, entre los 7 y 14 días y durante la sexta semana. Las visitas domiciliarias durante la primera semana son recomendadas cuando son factibles y aceptadas por la familia(4). La guía de NICE recomienda que el primer contacto presencial ocurra dentro de las 36 horas posteriores a la transferencia desde el lugar del parto o después de un parto domiciliario, y considera una visita adicional entre los 7 y 14 días(6).

En consecuencia, la clasificación inicial del riesgo no debe considerarse definitiva. En cada visita deben verificarse nuevos síntomas, evolución de hallazgos previos, cumplimiento de controles y remisiones, cambios en la alimentación, condiciones emocionales de la mujer y los miembros de la familia, funcionamiento familiar y capacidad del hogar para sostener los cuidados.

- ***Preparación de la visita y recuperación de información previa.***

La valoración en el hogar debe garantizar continuidad, por lo que es indispensable que el equipo revise o conozca la historia clínica, los antecedentes prenatales y obstétricos, las condiciones del parto, el resumen de egreso, los resultados de tamizajes y las remisiones pendientes(6,7). Entre los antecedentes relevantes se incluyen prematuridad, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento, necesidad de reanimación, infección o exposición infecciosa, anomalías congénitas, ingreso neonatal, dificultades de alimentación, hipertensión o preeclampsia, hemorragia, infección materna, enfermedad crónica, morbilidad materna extrema o ingreso de la mujer a unidad de cuidado intensivo, complicaciones quirúrgicas y antecedentes de salud mental(8).

También debe verificarse la continuidad de la información entre el prestador donde ocurrió el parto, el nivel primario, la aseguradora y el equipo domiciliario. NICE señala que la transferencia del cuidado debe incluir información sobre embarazo, parto, complicaciones, plan de atención, problemas actuales o previos de salud mental, situaciones de protección, preocupaciones planteadas por la familia o los profesionales y alimentación del recién nacido(6). La ausencia de esta información, de resultados pendientes o de un plan claro de seguimiento constituye por sí misma un riesgo para la continuidad del cuidado.

- ***Valoración de la mujer en posparto.***

La valoración materna en el hogar debe combinar entrevista, observación, signos vitales cuando correspondan al perfil profesional y los recursos disponibles, identificación de signos de alarma y revisión del acceso a los controles clínicos. La OMS recomienda indagar por el bienestar general, micción, función intestinal, cicatrización de heridas perineales o quirúrgicas, cefalea, fatiga, dolor lumbar o perineal, higiene, dolor mamario, sensibilidad uterina y características de los loquios. La revisión inicial debe considerar además sangrado, temperatura, pulso, frecuencia respiratoria y presión arterial(4). El aumento de la frecuencia respiratoria, especialmente si se acompaña de fiebre, taquicardia o malestar general, puede ser un signo temprano de sepsis puerperal y requiere valoración médica oportuna.

En cada contacto debe buscarse activamente sangrado abundante o creciente, coágulos, fiebre, escalofríos, flujo fétido, dolor abdominal o pélvico intenso, cefalea persistente o severa, alteraciones visuales, dolor torácico, dificultad respiratoria, dolor o edema unilateral de una extremidad, con o sin dificultad para la deambulación, deterioro general y problemas en las heridas. La presencia de estos hallazgos no debe someterse a una suma de puntajes ni diferirse hasta completar los demás instrumentos, sino que debe activar la valoración urgente o la ruta correspondiente(5).

La Escala Obstétrica de Alerta Temprana incluida en la RIA-MP puede apoyar la interpretación sistemática de presión arterial, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, temperatura, oxigenación y estado de conciencia(5). Sin embargo, fue planteada principalmente para la detección del deterioro clínico dentro de los servicios de salud y no se identificó evidencia de validación específica para su utilización autónoma en visitas domiciliarias. Por ello, puede emplearse como referente para estandarizar la valoración fisiológica cuando el equipo disponga de competencia y equipos adecuados, pero no debe reemplazar el juicio clínico ni retrasar la remisión. Su uso es especialmente útil cuando se identifican constantes vitales alteradas.

- ***Salud mental de la mujer.***

La salud mental debe explorarse en todos los contactos posnatales. La OMS recomienda el tamizaje de depresión y ansiedad mediante un instrumento validado, como la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo (EPDS) o el Patient Health Questionnaire-9, siempre que se encuentre acompañado de servicios de confirmación diagnóstica, manejo y seguimiento(4). La evidencia analizada por la OMS muestra que los programas efectivos no se limitaron a aplicar una escala, sino que vincularon los resultados positivos con evaluación clínica, consejería, intervenciones psicológicas o tratamiento(4).

La EPDS es aplicable durante la visita domiciliaria, pero debe utilizarse como instrumento de tamizaje y no como diagnóstico. Además del puntaje, el equipo debe explorar tristeza persistente, ansiedad, desesperanza, culpa, anhedonia, agotamiento extremo, pensamientos intrusivos, dificultades de vinculación con el recién nacido, disminución de la capacidad funcional, ideación suicida y síntomas psicóticos(4,6). Cualquier respuesta positiva relacionada con autolesión, riesgo de daño, psicosis o incapacidad grave para cuidar de sí misma o del recién nacido requiere evaluación inmediata y activación de la ruta de urgencias y salud mental(4).

- ***Valoración clínica y funcional del recién nacido.***

La valoración neonatal en el hogar debe integrar antecedentes, preocupaciones de la familia, observación directa, examen físico básico y verificación de los controles y tamizajes. La RIA-MP establece que el seguimiento debe valorar adaptación a la vida extrauterina, estado nutricional, alimentación, micción, deposiciones, signos de infección y posibles preocupaciones de los padres(5). También debe verificarse la realización o programación de los tamizajes metabólicos, auditivos y de cardiopatías congénitas, así como la disponibilidad y actualización del carné de salud infantil o sus análogos(6).

NICE recomienda utilizar el sistema Baby-Check o Newborn and Infant Physical Examination (NIPE)[1], un tipo de tamizaje físico que es utilizado en el sistema de salud del Reino Unido, y permite identificar tempranamente anomalías congénitas o alteraciones detectables en cuatro componentes: ojos, corazón, caderas y testículos, estos últimos cuando corresponda. Busca facilitar la valoración especializada y el tratamiento oportuno para reducir complicaciones, discapacidad y mortalidad evitables.

El sistema contempla dos momentos:

- Examen neonatal: debe completarse antes o al cumplir las primeras 72 horas de vida, preferiblemente antes del egreso hospitalario.
- Examen infantil: se repite entre las 6 y 8 semanas, generalmente en atención primaria.

[1] Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/newborn-and-infant-physical-examination-programme-handbook/newborn-and-infant-physical-examination-screening-programme-handbook

Tabla 2. Valoración del Baby-Check o NIPE

Componente	Propósito principal
Ojos	Detectar principalmente cataratas congénitas mediante inspección y evaluación del reflejo rojo. Un resultado anormal requiere remisión rápida a oftalmología.
Corazón	Reconocer signos compatibles con cardiopatías congénitas mayores o críticas mediante antecedentes, observación, palpación, auscultación y valoración clínica general. Un hallazgo positivo requiere evaluación neonatal o pediátrica oportuna según la gravedad. Cuando el tamizaje con oximetría de pulso no se haya realizado o no esté registrado antes del egreso, y el equipo disponga de oxímetro con sensor neonatal y entrenamiento, puede realizarse la medición preductal (mano derecha) y posductal (cualquier pie) con el recién nacido tranquilo y caliente. Una saturación menor de 90 % en cualquier extremidad requiere remisión inmediata; valores entre 90 % y 94 % en ambas extremidades, o una diferencia mayor de 3 puntos entre mano derecha y pie, requieren repetir la medición y, si persisten, remisión para valoración pediátrica y ecocardiograma. Un resultado normal no descarta la cardiopatía cuando existen otros signos clínicos.
Caderas	Identificar caderas luxadas, luxables o con riesgo de displasia. Incluye antecedentes familiares, presentación de nalgas, observación y maniobras de Barlow y Ortolani; los hallazgos positivos conducen a ecografía y valoración especializada.
Testículos	Verificar su presencia y descenso al escroto e identificar testículos no descendidos u otras anomalías que requieran seguimiento o remisión.

Fuente: Elaboración a partir de NIPE, NHS (2025).

El proceso incluye:

- Información previa a los padres sobre los objetivos y limitaciones del tamizaje.
- Obtención y registro del consentimiento.
- Realización del examen por un profesional con formación y competencia acreditadas.
- Clasificación de cada componente como resultado negativo o positivo.
- Información a la familia y activación de la ruta de remisión cuando corresponda.
- Seguimiento hasta confirmar que la valoración especializada y la decisión clínica se realizaron.
- Repetición del examen a las 6–8 semanas, incluso cuando el resultado neonatal fue normal.

El NIPE no es una herramienta de valoración integral de la familia ni un instrumento diseñado específicamente para visitas domiciliarias. Su aporte al PICF sería establecer un criterio verificable de continuidad del

cuidado durante la visita al hogar, el equipo puede confirmar si el examen neonatal fue realizado antes de las 72 horas, revisar sus resultados, identificar remisiones pendientes, comprobar que la familia comprende los hallazgos y asegurar la realización del segundo examen entre las 6 y 8 semanas. La exploración especializada de ojos, corazón, caderas y testículos debe ser realizada por personal con competencia clínica para el NIPE y por lo tanto requiere entrenamiento.

En términos generales, la guía de NICE recomienda que en el hogar se realice una valoración neonatal considere apariencia, color, actividad, postura, comportamiento, respiración, corazón, pulmones, abdomen, cordón umbilical, piel, tono, movimientos y características del llanto(9). El peso y el perímetro cefálico deben medirse durante la primera semana y registrarse en las curvas correspondientes, aunque la profundidad del examen dependerá de las competencias del profesional y de las condiciones de la visita(8).

En cada contacto deben identificarse signos de peligro neonatal. La OMS incluye la revisión e indagación de aspectos como, la alimentación inadecuada, antecedente de convulsiones, frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto, tiraje torácico severo, ausencia de movimiento espontáneo, temperatura superior a 37,5 °C, temperatura inferior a 35,5 °C, ictericia durante las primeras 24 horas o color amarillo en palmas y plantas a cualquier edad(4). De manera complementaria, deben considerarse signos de peligro el aleteo nasal, el quejido, la somnolencia excesiva o letargia y la ictericia que progresa o no disminuye en el tiempo esperado según la edad gestacional (a término o pretérmino). La presencia de cualquiera de estos signos requiere remisión para evaluación adicional y la familia debe recibir instrucciones claras para buscar atención si aparecen entre visitas(8).

NICE amplía la vigilancia a palidez, coloración cenicienta, moteada o cianótica, falta de respuesta, llanto débil o agudo, quejido, dificultad respiratoria, rash que no desaparece con la presión, fontanela abombada, convulsiones, signos neurológicos, vómito bilioso o proyectivo y deshidratación(9). El sistema Baby Check puede ser explicado a los cuidadores como apoyo para decidir cuándo consultar, pero no sustituye la valoración profesional ni debe utilizarse como único mecanismo para descartar enfermedad grave(6).

- ***Valoración de la alimentación y la lactancia.***

La alimentación es un componente central de la valoración domiciliaria, porque permite identificar simultáneamente la calidad del cuidado, la capacidad de la familia y posibles enfermedades neonatales. El equipo debe observar directamente, cuando sea posible, una toma completa y

valorar postura, agarre, succión, deglución, comodidad de la mujer, frecuencia y duración de las tomas, uso de fórmula u otros líquidos, eliminación urinaria, deposiciones y evolución del peso.

La RIA Materno-Perinatal reconoce como instrumentos aplicables el carné de salud infantil y la lista de chequeo para valoración de la lactancia materna de la estrategia AIEPI(5). La visita domiciliaria está expresamente indicada cuando se requiere mejorar la técnica de lactancia, vigilar el cuidado o verificar el plan de un recién nacido con complicaciones o riesgos(5).

La dificultad para alimentarse, la disminución del número de tomas, la succión débil, el rechazo del alimento, la somnolencia excesiva, la disminución de la eliminación o la pérdida de peso deben considerarse posibles señales de enfermedad y no tratarse únicamente como problemas educativos. Estos hallazgos requieren valoración clínica o seguimiento prioritario según la condición general del recién nacido(10).

- ***Valoración de la ictericia.***

La inspección del recién nacido en el hogar debe incluir la búsqueda de ictericia, especialmente durante los primeros días. NICE advierte que la identificación visual puede ser difícil, particularmente en recién nacidos con tonos de piel oscuros, y que la concentración de bilirrubina no debe estimarse únicamente mediante observación. Los padres deben recibir información sobre cómo revisar la piel, las escleróticas y las encías, la importancia de la ictericia durante las primeras 24 horas y la necesidad de observar orina oscura o deposiciones pálidas(6,9).

La ictericia durante las primeras 24 horas, su progresión rápida, la coloración amarilla de palmas y plantas, la asociación con somnolencia o mala alimentación, o su persistencia más allá de los periodos esperados requieren activación de la atención institucional para medición objetiva de bilirrubina y evaluación clínica. La medición sérica de bilirrubina, los umbrales de tratamiento y la investigación etiológica son procedimientos institucionales. Cuando el equipo disponga de bilirrubinómetro transcutáneo y entrenamiento, este puede utilizarse en el hogar en recién nacidos de 35 semanas o más y con más de 24 horas de vida como apoyo para decidir la remisión y evitar consultas innecesarias, sin reemplazar la valoración clínica; la inspección visual no debe utilizarse como único método para estimar el nivel de bilirrubina. La coloración amarilla de palmas y plantas (zonas 4 y 5 de Kramer) exige remisión inmediata, y el propósito de la vigilancia domiciliaria es detectar la ictericia antes de que alcance estas zonas. En todos los casos corresponde reconocer el riesgo, verificar antecedentes, educar y garantizar la canalización(9).

- ***Valoración familiar y capacidad de cuidado.***

La valoración domiciliaria debe reconocer a la familia como unidad de cuidado y no limitarse a sumar los riesgos individuales de la mujer y el recién nacido(11). El equipo debe identificar quién asume el cuidado principal, quién puede relevarlo, cómo se distribuyen las tareas, quién toma decisiones, qué personas pueden acompañar una remisión y qué apoyos emocionales, prácticos y económicos se encuentran disponibles.

La observación debe explorar la capacidad demostrada de los cuidadores para alimentar, cargar, abrigar, acostar y asear al recién nacido; cuidar el cordón(12); administrar tratamientos; reconocer signos de alarma; y explicar qué harían y a dónde acudirían ante una complicación(13). La OMS recomienda valorar las habilidades y la confianza de padres y cuidadores para atender al recién nacido, además de los factores del hogar que pueden afectar el cuidado y la búsqueda de atención.

En el PICF, la valoración familiar se apoya en la ficha familiar y en SIBACOM PLUS, junto con el familiograma, el APGAR familiar, el ecomapa y la Escala de Zarit. Estos instrumentos permiten caracterizar, respectivamente, la estructura y relaciones familiares, la percepción de funcionalidad y apoyo, la conexión con redes y recursos externos y la posible sobrecarga del cuidador. Su aplicación debe complementarse con observación y análisis clínico, pues el sistema también debe registrar riesgos o necesidades no incluidos inicialmente en la ficha(11).

El familiograma resulta útil para identificar estructura familiar, convivientes, relaciones, antecedentes y personas significativas para el cuidado. El APGAR familiar permite explorar la percepción de apoyo, participación, adaptación, afecto y capacidad resolutiva de la familia. El ecomapa identifica vínculos con servicios de salud, familia extensa, vecinos, organizaciones comunitarias y otros sectores, así como relaciones débiles, conflictivas o inexistentes que pueden dificultar el cuidado o la remisión(11).

Estos instrumentos deben interpretarse de manera conjunta y contextualizada. No se encontró evidencia de que el APGAR familiar, el familiograma o el ecomapa predigan por sí solos complicaciones maternas o neonatales. La Escala de Zarit tampoco es un instrumento específico del posparto ni de familias con recién nacidos; su uso resulta especialmente pertinente cuando existe una situación concreta de cuidado intensivo, dependencia, enfermedad o sobrecarga. Por ello, sus resultados deben orientar la indagación y la planificación del cuidado, pero no utilizarse de manera aislada para determinar el nivel de riesgo materno-neonatal.

La revisión de Kocakabak y colaboradores identificó múltiples medidas relacionadas con estrés, depresión, ansiedad, autoeficacia parental, preparación para el egreso, funcionamiento familiar, interacción y

vínculo(13). Sin embargo, encontró 97 instrumentos para 60 desenlaces, con considerable heterogeneidad y aplicación predominante en unidades neonatales hospitalarias(13). Estos instrumentos pueden constituir un banco de referencia, pero no conforman una batería validada para estratificar familias con recién nacidos en el entorno hogar.

- ***Riesgo psicosocial, violencia y protección.***

La valoración debe incluir, en un espacio privado y seguro, preguntas sobre violencia de pareja o intrafamiliar, consumo de sustancias (incluido el alcohol), aislamiento, inseguridad alimentaria, salud mental de los cuidadores, conflictos familiares, ausencia de apoyo y condiciones que puedan afectar la seguridad del recién nacido. La evidencia de la U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF) reconoce como factores asociados con maltrato o negligencia el estrés parental, depresión, consumo de sustancias, violencia familiar, desconocimiento de las necesidades del niño, dificultades en las habilidades de cuidado, aislamiento social y desventaja socioeconómica. No obstante, concluye que la evidencia es insuficiente para recomendar un instrumento universal que prediga el maltrato infantil(8).

En consecuencia, estos factores deben utilizarse para orientar una valoración más profunda y activar los protocolos de protección cuando exista sospecha razonable, no para etiquetar automáticamente a una familia. La pobreza, ruralidad, edad materna o composición familiar no deben interpretarse por sí solas como negligencia. La clasificación debe basarse en la integración de las condiciones, la capacidad efectiva de cuidado, la seguridad del recién nacido y la existencia de daño o amenaza(8).

- ***Valoración del entorno y del acceso a los servicios.***

El hogar debe valorarse como un componente activo del riesgo. La observación debe incluir el espacio donde duerme el recién nacido, posición para dormir, superficie y objetos presentes, exposición al humo, temperatura, ventilación, disponibilidad de agua segura, higiene, manejo del cordón, presencia de animales, hacinamiento, almacenamiento de medicamentos y sustancias peligrosas y condiciones para el descanso y la recuperación de la mujer(4).

También deben valorarse las condiciones que determinan la posibilidad efectiva de activar una ruta como, por ejemplo, la distancia al servicio, transporte disponible, recursos económicos, cobertura telefónica, afiliación, conocimiento de los puntos de atención, horarios, acompañante para el traslado, barreras lingüísticas o culturales y experiencias previas de discriminación. La visita domiciliaria puede mejorar la equidad al acercar el cuidado a familias rurales o con menores recursos, aunque su

factibilidad depende de disponibilidad de personal, transporte, tiempo, equipos y coordinación con los servicios(4).

- ***Instrumentos y procedimientos según su aplicabilidad en el hogar.***

La evidencia permite organizar los recursos de valoración en tres grupos. En primer grupo, los directamente aplicables durante la visita domiciliaria la ficha familiar, el familiograma, el APGAR familiar, el ecomapa, la EPDS, la lista de signos de peligro maternos y neonatales, la lista AIEPI de valoración de la lactancia, el carné de salud infantil y la observación estructurada del entorno y de las prácticas de cuidado(4,5).

En el segundo grupo, se encuentran los instrumentos que pueden utilizarse como apoyo condicionado al perfil profesional, a la disponibilidad de equipos y a una ruta de respuesta como la Escala Obstétrica de Alerta Temprana (incluida en los lineamientos técnicos y operativos de la RIA M-P adoptados mediante la Resolución 3280 de 2018), Baby Check y la Escala de Zarit. Estos instrumentos no constituyen por sí mismos sistemas integrales de estratificación y no deben reemplazar el juicio clínico ni la evaluación familiar(6).

Un último grupo son los procedimientos que deben verificarse durante la visita, pero su ejecución corresponde principalmente al ámbito institucional, entre ellos, la bilirrubinometría, tamizajes metabólicos, auditivos y de cardiopatías congénitas, exámenes diagnósticos ante infección o anemia y estudios para complicaciones maternas. El papel del equipo domiciliario consiste en confirmar su realización, revisar resultados disponibles, identificar retrasos o hallazgos preocupantes y garantizar la activación efectiva del servicio correspondiente(4).

- ***Estratificación del riesgo.***

A partir de la evidencia, es posible establecer una clasificación del riesgo que se base en el hallazgo de mayor gravedad dentro de cualquiera de los dominios y no exclusivamente en la suma de puntuaciones. En esta línea se han podido identificar tres niveles de riesgo posibles:

1. El riesgo inmediato o crítico incluye signos de alarma maternos o neonatales, deterioro clínico, ideación suicida, psicosis, violencia o amenaza inmediata, sospecha de maltrato grave, incapacidad para satisfacer necesidades esenciales o una condición ambiental que represente peligro inminente. Requiere activación inmediata de la ruta, comunicación con el servicio receptor y verificación posterior de la atención(4,6,8,10).
2. El riesgo alto o de seguimiento prioritario comprende prematuridad, bajo peso, complicaciones perinatales, dificultades persistentes de

alimentación, ictericia con factores de riesgo, enfermedad materna o complicación obstétrica reciente, tamizaje positivo de salud mental sin peligro inmediato, apoyo familiar insuficiente, baja competencia o confianza del cuidador, violencia no inminente, inseguridad alimentaria, condiciones inadecuadas de vivienda o barreras graves de acceso. Requiere visita temprana, mayor frecuencia de seguimiento, plan explícito, participación interdisciplinaria y verificación de remisiones y compromisos(4,9).

3. El riesgo habitual con seguimiento programado corresponde a una mujer y un recién nacido clínicamente estables, con alimentación adecuada, ausencia de signos de alarma, controles y tamizajes programados, cuidadores con capacidad demostrada, red de apoyo disponible y condiciones razonablemente seguras en el hogar. Esta clasificación no implica cierre del seguimiento; deben mantenerse los contactos recomendados, la educación y la reevaluación periódica(5).

En general, la mejor evidencia disponible respalda un proceso de valoración domiciliaria integrada, y no la adopción de una escala única. Este proceso debe combinar cuatro fuentes: información clínica previa; valoración materna y neonatal breve y estructurada; aplicación selectiva de instrumentos de salud mental, alimentación y funcionamiento familiar; y observación directa del hogar, las relaciones, las prácticas de cuidado y las barreras de acceso. Cada hallazgo debe vincularse con una conducta, un responsable, un plazo y un mecanismo de verificación.

Para el PICF, la ficha de valoración de la familia con recién nacido debería incorporar como mínimo: antecedentes maternos y perinatales; valoración clínica y signos de alarma de la mujer; salud mental; estado, alimentación y signos de peligro del recién nacido; ictericia; capacidades y confianza de los cuidadores; estructura y funcionamiento familiar; redes de apoyo; violencia y protección; condiciones de vivienda; barreras de acceso; clasificación del riesgo; ruta activada; y resultado del seguimiento. El instrumento debe permitir comparar visitas sucesivas y documentar no solo riesgos, sino también fortalezas y cambios en la capacidad familiar de cuidado.

8.2 Pregunta 2.

En familias con recién nacidos y mujeres en posparto atendidas en el entorno hogar, ¿qué intervenciones familiares estructuradas son efectivas y factibles para mejorar resultados de salud neonatal, materna-posparto y de cuidado familiar, y qué componentes deben estandarizarse en el PICF?

La evidencia revisada favorece la implementación de un paquete familiar estructurado, longitudinal y diferenciado según el riesgo, más que la realización de una actividad educativa aislada o una visita domiciliaria sin contenidos y procedimientos definidos. Los componentes con mayor respaldo identificados incluyen el contacto posnatal temprano en el hogar; la valoración conjunta de la mujer y del recién nacido; la educación práctica y personalizada; el apoyo directo a la lactancia; la promoción de prácticas esenciales de cuidado neonatal; el apoyo psicosocial y de salud mental; la participación de la pareja y de otros cuidadores elegidos por la mujer; el fortalecimiento de competencias parentales; los registros disponibles en el hogar; la comunicación continua con el equipo de salud, y los mecanismos de canalización, remisión y seguimiento con comprobación de uso o acceso a estos mecanismos.

Los efectos no son homogéneos para todos los desenlaces. La evidencia más consistente se observa en la reducción de la mortalidad neonatal cuando las visitas domiciliarias se comparan con la ausencia de visita, en la mejora de la iniciación, duración y exclusividad de la lactancia mediante intervenciones estructuradas de consejería, y en la reducción de síntomas de depresión o ansiedad mediante intervenciones psicosociales o psicológicas. Para otros resultados, como reingresos, morbilidad materna, uso de urgencias o lactancia cuando la visita domiciliaria se compara con un control ambulatorio de buena calidad, los efectos son pequeños, inciertos o inexistentes. Por ello, la visita domiciliaria debe entenderse como una plataforma para entregar un conjunto de intervenciones, y no como una intervención efectiva por el solo hecho de ocurrir en el hogar.

La evidencia disponible también muestra que la efectividad depende de la calidad de la implementación. Los programas con mejores resultados combinan personal capacitado, contenidos estandarizados, observación y práctica de habilidades, repetición de los contactos, adaptación a las necesidades familiares, supervisión del talento humano, materiales de apoyo, registro de hallazgos y conexión con servicios resolutivos.

- ***Visita domiciliaria posnatal como plataforma de intervención.***

La OMS recomienda visitas domiciliarias durante la primera semana después del nacimiento, realizadas por personal cualificado o por trabajadores comunitarios entrenados(4). La evidencia que compara visitas posnatales con ausencia de visitas muestra que estas probablemente reducen la mortalidad neonatal, con un riesgo relativo de 0,76 —IC 95 %: 0,62 a 0,92— en nueve ensayos con 93.083 recién nacidos. También podrían reducir la diarrea durante los primeros 42 días —RR 0,85; IC 95 %: 0,74 a 0,98—. No obstante, los efectos sobre morbilidad materna grave, fiebre, dolor, complicaciones urinarias,

inmunización, ictericia y uso no programado de servicios fueron pequeños o inciertos(4).

Cuando la visita domiciliaria se compara con una consulta ambulatoria posnatal, y no con ausencia de atención, la superioridad es menos clara. La evidencia sugiere poco o ningún efecto sobre lactancia exclusiva hasta las seis semanas, continuidad de cualquier lactancia, utilización de servicios infantiles o reingresos hospitalarios. Sin embargo, las visitas podrían mejorar la satisfacción materna con la atención —RR 1,36; IC 95 %: 1,14 a 1,62—, y son valoradas por la posibilidad de recibir orientación, tranquilidad y apoyo emocional en el contexto real donde ocurren las dificultades(4).

Estos hallazgos indican que no debe atribuirse un efecto automático a cualquier visita. El valor adicional del hogar se obtiene cuando el contacto permite:

- ✓ observar una toma y corregir la técnica de alimentación;
- ✓ verificar las prácticas reales de sueño, higiene, termorregulación y cuidado del cordón;
- ✓ identificar dificultades emocionales, familiares o sociales;
- ✓ valorar la capacidad de los cuidadores;
- ✓ resolver dudas en el momento en que ocurren;
- ✓ detectar signos de alarma;
- ✓ asegurar que las remisiones y controles se materialicen.

Para familias sin barreras de acceso y con atención ambulatoria oportuna y de calidad, el beneficio clínico adicional de una visita universal puede ser menor. En cambio, el valor probablemente aumenta en familias con recién nacidos de riesgo, primigestantes, madres adolescentes, dificultades de alimentación, problemas de salud mental, barreras geográficas, bajo apoyo familiar o menor capacidad para reconocer y responder ante complicaciones(4,10).

La OMS considera que en el balance riesgo-beneficio, las visitas resultan favorables porque pueden mejorar la equidad y porque son generalmente aceptables, aunque su factibilidad varía. Los principales obstáculos son las distancias, condiciones de las vías, transporte, carga laboral y disponibilidad de personal(4). En programas de países de ingresos bajos y medios, la mayoría de las visitas se concentró en las primeras dos semanas y fue desarrollada por personal cualificado o trabajadores comunitarios entrenados(4).

La implementación requiere personal designado y capacitado, registros familiares, formatos de remisión, tarjetas de consejería, medios de comunicación, balanza, termómetro, reloj o temporizador y transporte. Los programas comunitarios evaluados utilizaron entre 23 y 45 minutos

por visita, además del tiempo de preparación, desplazamiento y registro(4).

- ***Educación práctica y preparación para el cuidado en casa.***

La educación familiar debe superar la entrega de información general. Las mujeres y sus familias valoran intervenciones que aumenten su confianza y les permitan practicar el cuidado con acompañamiento profesional(4,13). La OMS recomienda proporcionar información, educación y consejería para preparar la transición al hogar, mediante materiales escritos, digitales o pictográficos adaptados a las capacidades de lectura y al contexto cultural. Sin embargo, la certeza sobre el efecto de la educación de egreso como intervención aislada es muy baja. Un estudio no aleatorizado encontró mayor preparación para el egreso en el grupo intervenido —92,5 % frente a 67,5 %—, pero la evidencia general sobre programas educativos posnatales y resultados clínicos del recién nacido permanece insuficiente(4).

Esta incertidumbre no significa que la educación carezca de valor, sino que debe evitarse asumir que entregar información produce automáticamente cambios. Para aumentar su utilidad, el componente educativo debe incluir(4,8,10):

- selección de contenidos según las necesidades observadas;
- explicación breve y en lenguaje comprensible;
- demostración práctica;
- práctica realizada por la mujer o el cuidador;
- corrección respetuosa;
- verificación de comprensión mediante la técnica de "enséñeme cómo lo haría";
- acuerdo explícito sobre qué hacer ante una dificultad;
- seguimiento en la visita siguiente.

Los contenidos mínimos deben abarcar cuidado y recuperación materna; lactancia y otras formas seguras de alimentación cuando correspondan(10); higiene de manos; termorregulación; cuidado limpio y seco del cordón (con higiene de manos, sin aplicar sustancias sobre el muñón y con orientación adaptada a las condiciones de saneamiento del hogar; la clorhexidina se reserva para contextos donde es frecuente la aplicación de sustancias tradicionales nocivas); sueño seguro; signos de alarma maternos y neonatales; eliminación; ictericia; vacunación y tamizajes; vínculo afectivo; asistencia a controles; y rutas de contacto(4–6,9). No todos estos temas deben abordarse con la misma profundidad en una única visita. La educación debe priorizarse según la edad del recién nacido, el riesgo y los problemas identificados.

NICE recomienda que la información sea individualizada, sensible, consistente y basada en evidencia; que se entregue presencialmente y pueda complementarse con formatos impresos, virtuales o accesibles; y que el profesional compruebe que la mujer comprendió cómo aplicar la información a su situación(6). En zonas rurales dispersas o con barreras de acceso, los materiales educativos digitales y el seguimiento telefónico o por mensajería pueden constituir el principal medio de apoyo a la familia, por lo que se recomienda disponer de materiales validados y adaptados culturalmente que puedan compartirse por estos canales.

- ***Apoyo estructurado a la lactancia***

Las intervenciones de apoyo a la lactancia tienen uno de los respaldos más claros dentro de la evidencia seleccionada. La USPSTF concluye que las intervenciones conductuales de consejería proporcionan un beneficio neto moderado y mejoran la iniciación, duración y exclusividad de la lactancia; sus daños se estiman como pequeños(10).

Las intervenciones efectivas combinan educación sobre beneficios y expectativas realistas, enseñanza de habilidades, observación directa de la alimentación, corrección de postura y agarre, apoyo emocional, solución de problemas y manejo inicial de dificultades frecuentes(10). Pueden ser proporcionadas por enfermería, medicina, partería, profesionales de lactancia o pares entrenados, de manera presencial, domiciliaria, telefónica, por video o mensajería. Los programas que abarcan más de un momento, desde lo prenatal, el periparto y el posparto tienden a tener mayores efectos que los contactos únicos. La participación de pareja, familiares o amigos puede utilizarse para enseñar formas concretas de apoyar a la mujer y evitar recomendaciones familiares contradictorias(10).

Por tanto, la intervención en el marco de la visita a la familia, debe incluir, cuando sea posible, la observación de una toma completa y la valoración de:

- ✓ Posición de la mujer y del bebé.
- ✓ Agarre.
- ✓ Succión y deglución.
- ✓ Dolor o lesiones.
- ✓ Percepción de producción.
- ✓ Frecuencia y duración de las tomas.
- ✓ Signos de alimentación suficiente.
- ✓ Diuresis, deposiciones y evolución del peso.
- ✓ Uso de fórmula u otros líquidos sin indicación médica, biberones o chupos, como posibles barreras para la lactancia materna exclusiva.
- ✓ Creencias y presiones familiares.

- ✓ Disponibilidad de apoyo para descanso, alimentación y recuperación materna.

El apoyo debe ser respetuoso y evitar mensajes culpabilizantes. La USPSTF reconoce la necesidad de valorar los posibles efectos emocionales negativos de intervenciones inadecuadamente comunicadas, como culpa, vergüenza, ansiedad o sensación de fracaso(10).

En contextos afectados por conflicto o fragilidad, las intervenciones de consejería sobre lactancia, apoyo telefónico y educación a madres también mostraron efectos positivos en conocimientos, prácticas y cobertura(7). La revisión de Moutwakil identificó intervenciones mediante sesiones prenatales, grupales, domiciliarias y apoyo móvil, y encontró resultados favorables especialmente para promoción de la lactancia, contacto piel a piel, cuidado del cordón y estrategias de mejora de calidad(7).

- ***Prácticas esenciales de cuidado neonatal desarrolladas con la familia.***

Las intervenciones familiares deben traducir las recomendaciones clínicas en habilidades observables. La OMS recomienda lactancia exclusiva, cuidado limpio y seco del cordón, posición supina para dormir, vacunación según el esquema vigente, cuidado sensible y actividades tempranas de interacción(4). También recomienda que los padres reciban apoyo para proporcionar cuidado responsivo, es decir una persona cuidadora con capacidad para percibir, interpretar y responder a las señales físicas o emocionales del recién nacido de forma rápida, adecuada y constante y reconocer las señales de riesgo o peligro(4,6).

La revisión de Moutwakil(7), aunque realizada en escenarios de conflicto y por tanto de aplicabilidad indirecta, aporta evidencia sobre intervenciones neonatales que pueden mantenerse fuera de infraestructuras complejas. De 32 estudios, 8 de 10 que evaluaron cobertura y 7 de 12 que evaluaron resultados en salud informaron efectos positivos. Los mejores resultados se observaron en programas de lactancia, contacto piel a piel o método madre canguro, cuidado del cordón con clorhexidina en contextos indicados y mejora de calidad. El 84% de las intervenciones incorporó capacitación de trabajadores comunitarios, lo que subraya la importancia de la formación, supervisión y apoyo continuo al talento humano(7).

La aplicabilidad al PICF debe distinguir entre recién nacidos sanos y recién nacidos prematuros, con bajo peso o antecedentes de hospitalización. En los segundos, la familia puede requerir enseñanza estructurada sobre contacto piel a piel, conservación de la temperatura, extracción y administración de leche materna, administración de medicamentos,

asistencia a controles y reconocimiento de deterioro. No obstante, el método madre canguro y otras intervenciones para recién nacidos pequeños o enfermos deben articularse con los programas clínicos correspondientes y no reemplazarse por acompañamiento domiciliario general.

La educación específica sobre ictericia también puede incorporarse en las estrategias que despliega el equipo. NICE recomienda ofrecer información verbal apoyada por material escrito, adaptada a las preocupaciones familiares, que incluya factores de riesgo, forma de observar al bebé y situaciones que requieren consulta. La valoración visual en casa sirve para reconocer una posible alteración, pero no sustituye la medición objetiva de bilirrubina(9).

- ***Intervenciones psicosociales y de salud mental.***

La OMS recomienda intervenciones psicosociales o psicológicas durante el periodo prenatal y posnatal para prevenir depresión y ansiedad. La evidencia procede de 44 estudios con 23.542 mujeres. Las intervenciones psicosociales incluyeron psicoeducación, visitas domiciliarias de profesionales o agentes entrenados y apoyo social; las psicológicas incluyeron terapia cognitivo-conductual, terapia interpersonal, mindfulness, intervenciones mente-cuerpo y monitoreo del estado de ánimo(4). Estas intervenciones fueron proporcionadas por especialistas, profesionales entrenados, pares o parejas(4).

Las intervenciones con componentes prenatales y posnatales probablemente reducen la intensidad de los síntomas depresivos, 14 ensayos, 3.485 mujeres; diferencia media de 0,10 puntos menos. Las intervenciones exclusivamente posnatales probablemente reducen la gravedad de la ansiedad, cuatro ensayos, 1.193 mujeres; diferencia media de 0,45 puntos menos, aunque su efecto sobre la gravedad de la depresión es incierto(4). Tanto las intervenciones universales como las dirigidas a mujeres con factores de riesgo mostraron reducciones de síntomas depresivos, sin diferencias estadísticamente concluyentes entre ambos enfoques(4).

Para el PICF, esta implementación puede incluir un modelo escalonado así:

a. Componente general: preguntar por bienestar emocional; normalizar la conversación; brindar psicoeducación sobre cambios del posparto; enseñar estrategias de afrontamiento; promover descanso, apoyo práctico, comunicación y red familiar.
b. Componente selectivo: seguimiento más frecuente para mujeres adolescentes, con antecedentes de depresión, síntomas

subumbrales, violencia, bajo apoyo, pobreza u otros factores sociales.

c. Componente indicado: canalización efectiva a valoración diagnóstica y tratamiento cuando el tamizaje o la entrevista identifican síntomas clínicamente significativos.

La aplicación de una escala sin posibilidad de respuesta no constituye una intervención suficiente. El apoyo debe estar vinculado con rutas de diagnóstico, psicología, psiquiatría, trabajo social, urgencias o aquella que el equipo valore y considere necesarias. También conviene mantener continuidad del profesional o del equipo, debido a que las mujeres valoran la relación de confianza y la sensibilidad frente a sus circunstancias(4).

- ***Participación de la familia, pareja y otros cuidadores.***

Las intervenciones centradas en la familia consideran a padres y cuidadores participantes activos del cuidado, y no receptores pasivos de instrucciones. Sus componentes comunes incluyen presencia, participación en cuidados, acceso a información, comunicación respetuosa, colaboración con profesionales y participación en decisiones. La revisión de Kocakabak identificó 42 estudios experimentales de cuidado neonatal centrado en la familia, pero encontró una heterogeneidad considerable: 60 desenlaces, 97 medidas y numerosos momentos de evaluación(13). Con base en esta revisión es posible considerar que las intervenciones se orientan a resultados neonatales y parentales, como alimentación, crecimiento, estancia hospitalaria, estrés, ansiedad, depresión, autoeficacia, satisfacción, participación y preparación para el cuidado favorecen la participación y consecución de logros.

La mayoría de estos estudios se desarrolló en unidades neonatales, con recién nacidos prematuros o enfermos. Su aplicabilidad al entorno hogar es indirecta, pero respalda principios transferibles como por ejemplo, la participación activa del cuidador, la enseñanza basada en competencias, la comunicación bidireccional, el reconocimiento del conocimiento familiar y el seguimiento de resultados tanto del recién nacido como de sus cuidadores, aunque es importante mencionar la elevada heterogeneidad obtenida dentro de los estudios.

La OMS recomienda involucrar a los padres desde el embarazo y durante el parto y el posparto para mejorar el autocuidado de la mujer, las prácticas de cuidado del recién nacido y la búsqueda oportuna de atención. La participación puede ofrecer apoyo práctico, emocional y económico y facilitar el acceso a servicios. Sin embargo, debe hacerse de manera que respete las decisiones y autonomía de la mujer y no refuerce relaciones de control o desigualdad(4).

Desde el entorno hogar, la intervención puede ser dirigirse a la red de cuidado elegida por la mujer, la cual puede incluir pareja, padre del bebé, familiares, amistades o vecinos. Las acciones deben concretarse en responsabilidades verificables dentro de las cuales están el relevo para el descanso, la preparación de alimentos, la división de tareas domésticas, acompañamiento a controles, vigilancia de signos de alarma, apoyo a la lactancia y disponibilidad para traslado en caso de emergencia(6).

- ***Prevención de negligencia, maltrato y desprotección.***

Los programas domiciliarios para familias con niños pequeños suelen integrar educación sobre el desarrollo infantil, orientación parental, solución de problemas, fortalecimiento de redes informales, promoción de interacciones positivas, seguridad ambiental, transporte y vinculación con servicios comunitarios. Sin embargo, la USPSTF concluyó que la evidencia era insuficiente para establecer que estas intervenciones previenen el maltrato en niños sin signos o síntomas. Los estudios fueron heterogéneos y presentaron resultados inconsistentes(8).

Por tanto, con base en la evidencia se sugiere incorporar este tipo de acciones como parte del apoyo familiar integral, pero no debe presentarlas como una estrategia de eficacia demostrada para prevenir por sí sola el maltrato. Esto implica que ante sospecha de violencia, negligencia o amenaza, corresponde activar los protocolos de protección, el equipo no debe mantener únicamente la educación domiciliaria, sino debe explorar explícitamente este fenómeno. También debe evitarse estigmatizar a las familias por su edad, pobreza, ruralidad o composición(8).

- ***Registros domiciliarios, comunicación y continuidad.***

La OMS recomienda el uso de registros disponibles en el hogar como complemento de los registros institucionales, dentro de los cuales considera cartillas, tarjetas o carnet plegables, entre otros. Estos pueden mejorar la comunicación entre familias y profesionales, la búsqueda de atención, la participación de la pareja, las prácticas de cuidado y la alimentación infantil. También recomienda, bajo condiciones apropiadas de seguridad y privacidad, comunicaciones digitales dirigidas para promover conductas de salud materna y neonatal(4).

Algunos de los datos que se recomiendan en la evidencia para el registro domiciliario como herramienta de cuidado, incluyen:

- Datos de contacto del equipo.
- Próximas citas y remisiones.
- Prácticas acordadas.
- Signos de alarma.

- Compromisos de cada cuidador.
- Resultado de la observación de la lactancia.
- Problemas pendientes.
- Fecha y objetivo del próximo contacto.

El seguimiento telefónico, por mensajería o video puede complementar la visita para resolver dudas, verificar evolución y reforzar acuerdos, pero no debe sustituir una valoración presencial cuando existen signos de alarma, dificultades importantes de alimentación, riesgo psicosocial o falta de claridad sobre el estado del recién nacido(6).

La RIA Materno-Perinatal colombiana dispone que las acciones educativas, familiares e individuales se integren dentro de un plan de cuidado construido con las mujeres y sus familias. También establece el fortalecimiento de redes familiares y comunitarias, la educación mediante diálogo de saberes y la participación de la familia en la planificación, seguimiento y evaluación de la atención(5).

- ***Factibilidad en territorios rurales y dispersos.***

La evidencia respalda la posibilidad de compartir algunas funciones con auxiliares de enfermería y trabajadores comunitarios entrenados en contextos de conflicto o difícil acceso, siempre que exista definición de competencias, capacitación, supervisión continua vía remota y acceso a profesionales para consulta y remisión. La revisión de Moutwakil muestra que los programas sostenidos por trabajadores locales, acompañados por supervisión y tecnologías móviles o audiovisuales, pueden mantener prácticas esenciales incluso en contextos de alta fragilidad(7).

Desde una valoración de la factibilidad en contextos rurales, la implantación de intervenciones para la atención y el cuidado en el entorno hogar, no depende únicamente de simplificar contenidos, se requieren algunos insumos que soporten el proceso dentro de los cuales se pueden establecer los siguientes:

  - Rutas territoriales de desplazamiento.
  - Tiempo protegido para las visitas.
  - Equipos portátiles.
  - Medios de comunicación.
  - Protocolos breves.
  - Supervisión clínica.
  - Mecanismos para consultar dudas.
  - Articulación con ESE, aseguradores y servicios de urgencias;
  - oferta social e intersectorial actualizada.

En familias con mayor riesgo o barreras de acceso deben aumentarse la intensidad y la participación interdisciplinaria. El lineamiento vigente del

PICF ya prioriza el posparto durante los primeros siete días, especialmente en primigestantes y mujeres con antecedentes de riesgo, y contempla cuidado especial o visitas en dupla cuando la vulnerabilidad lo exige(11).

En términos generales, la mejor evidencia disponible respalda una intervención familiar domiciliaria multicomponente, temprana, práctica y vinculada con la red de servicios. La visita domiciliaria puede reducir la mortalidad neonatal cuando se compara con la ausencia de seguimiento y puede mejorar la satisfacción y la equidad, pero no es necesariamente superior a una atención ambulatoria de alta calidad para todos los desenlaces. Sus beneficios dependen de que incluya valoración clínica y familiar, educación basada en habilidades, apoyo a la lactancia, salud mental, participación de cuidadores, detección de riesgos y activación efectiva de rutas.

Los componentes con respaldo más consistente para estandarizar son el apoyo estructurado a la lactancia, la educación práctica, las intervenciones psicosociales, el cuidado neonatal esencial, la participación familiar respetuosa, los registros domiciliarios y el seguimiento temprano. La intensidad debe adaptarse al riesgo: una intervención básica para todas las familias y componentes reforzados, interdisciplinarios y de mayor frecuencia para familias con vulnerabilidades clínicas, emocionales, sociales o territoriales.

8.3 Pregunta 3.

En recién nacidos, mujeres en posparto y familias atendidas en el entorno hogar, ¿qué signos de alarma y criterios de riesgo clínico, psicosocial, familiar o del entorno deben activar rutas de atención, remisión, seguimiento prioritario o respuesta intersectorial para garantizar oportunidad y continuidad del cuidado en el nivel primario?

La evidencia revisada muestra que la activación de rutas durante el posparto no debe depender exclusivamente de una escala o de la suma de múltiples factores. En el entorno hogar, la conducta debe definirse con base en el hallazgo de mayor gravedad identificado en la mujer, el recién nacido, la familia o el ambiente. Un solo signo de compromiso vital, deterioro clínico, riesgo de autolesión, violencia, desprotección grave o incapacidad para garantizar el cuidado básico debe prevalecer sobre cualquier clasificación general de bajo riesgo y activar una respuesta inmediata.

Las guías de la OMS(4), NICE(6) y la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal(5) coinciden en que los primeros días y semanas

posteriores al nacimiento constituyen un periodo de rápida transición, durante el cual pueden aparecer hemorragia, infección, trastornos hipertensivos, tromboembolismo, problemas de salud mental, dificultades de alimentación, infección neonatal, ictericia grave y otras complicaciones. Por esta razón, la identificación de riesgos debe realizarse en cada contacto y estar vinculada a un sistema funcional de remisión, comunicación, transporte y seguimiento. No es suficiente informar a la familia que debe consultar; el equipo debe verificar que la atención se haya hecho efectiva y que exista continuidad después de la remisión.

En el marco de entornos ambulatorios, la evidencia respalda que se pueda canalizar una respuesta escalonada teniendo en cuenta los hallazgos de la valoración así:

1. Activación inmediata de urgencias o emergencias, ante compromiso vital o posibilidad de deterioro rápido.
2. Valoración clínica urgente o el mismo día, ante signos que requieren examen, pruebas diagnósticas o tratamiento oportuno, aunque no exista inestabilidad manifiesta.
3. Seguimiento domiciliario prioritario, ante condiciones que aumentan la probabilidad de complicaciones o dificultan el cuidado, sin que exista todavía una emergencia.
4. Respuesta intersectorial y acompañamiento continuado, ante violencia, desprotección, inseguridad alimentaria, pobreza extrema, barreras de acceso, vivienda insegura u otras condiciones sociales que no pueden resolverse exclusivamente mediante atención clínica.

- ***Signos de alarma y criterios de riesgo en el recién nacido***

En cada contacto posnatal, el equipo debe preguntar a la familia si ha observado cambios en el bienestar, comportamiento, alimentación, respiración, color, temperatura, eliminación o nivel de respuesta del recién nacido. La preocupación persistente de los padres o cuidadores debe considerarse relevante, incluso cuando inicialmente no se identifique un signo aislado concluyente. NICE advierte que la presencia o ausencia de un síntoma individual tiene capacidad limitada para confirmar o descartar enfermedad grave en un recién nacido; por tanto, la decisión debe integrar antecedentes, evolución, observación profesional, percepción familiar y condiciones de acceso a los servicios(6).

La OMS recomienda evaluar en cada contacto posnatal la alimentación, los antecedentes de convulsiones, la respiración, los movimientos espontáneos, la temperatura y la ictericia. La identificación de cualquiera de sus signos de peligro exige remisión para valoración adicional, y la

familia debe ser capacitada para reconocerlos y buscar atención entre las visitas(4).

- *Compromiso general, neurológico o del estado de conciencia*

Debe activarse atención inmediata cuando el recién nacido:

- Está pálido, grisáceo, moteado o cianótico.
- No responde, es difícil de despertar o no presenta movimientos espontáneos.
- Presenta un llanto débil, continuo o anormalmente agudo.
- Tiene convulsiones o antecedentes recientes de convulsiones.
- Presenta fontanela abombada, rigidez de cuello o signos neurológicos focales.
- Muestra un cambio marcado de comportamiento o disminución de la capacidad de respuesta.

NICE considera estos hallazgos "banderas rojas" de enfermedad grave y recomienda evaluación inmediata por un servicio de emergencias. Si la condición parece amenazar de manera inmediata la vida, la activación debe ser directa y no condicionarse a completar el resto de la visita(6).

En el PICF, la ausencia de movimiento, la hipotonía intensa, la letargia, las convulsiones o la alteración progresiva de la respuesta deben conducir a la activación de urgencias, comunicación con el servicio de salud institucional más cercano y organización del traslado(11). No corresponde mantener al recién nacido en observación domiciliaria ni programar únicamente una nueva visita.

- *Signos respiratorios y cardiocirculatorios*

Los siguientes hallazgos requieren atención inmediata:

- Frecuencia respiratoria superior a 60 respiraciones por minuto.
- Aleteo nasal, quejido o tiraje torácico.
- Tiraje torácico marcado.
- Quejido respiratorio.
- Pausas respiratorias o apnea.
- Cianosis central o coloración azulada persistente.
- Dificultad respiratoria creciente.
- Perfusión deficiente, palidez marcada, frialdad o aspecto moteado.
- Fatiga o interrupción repetida de la alimentación por dificultad respiratoria.

La OMS incluye la respiración rápida y el tiraje torácico severo entre los principales signos de peligro neonatal(4). NICE añade el quejido, la cianosis y la impresión general de enfermedad grave(6). Cuando el equipo dispone de oxímetro y cuenta con competencia para utilizarlo, una saturación anormal puede apoyar la decisión, pero su ausencia no debe retrasar la remisión frente a signos clínicos evidentes. La RIA Materno-Perinatal exige vigilar el desempeño cardiorrespiratorio, la perfusión, el color, la actividad y la reactividad y derivar al recién nacido cuando existan hallazgos compatibles con una condición de riesgo(5).

- *Alteraciones de la temperatura e infección neonatal*

La OMS establece como signos de peligro una temperatura mayor de 37,5 °C o menor de 35,5 °C. NICE utiliza como banderas rojas temperatura igual o mayor de 38 °C o menor de 36 °C. La diferencia entre umbrales refleja los distintos protocolos de origen. En el contexto colombiano, los umbrales de la RIA Materno-Perinatal es el referente que debe adoptarse, utilizando el umbral más conservador cuando la alteración térmica se acompañe de mala alimentación, letargia, cambios respiratorios, coloración anormal o deterioro general(4,6).

La fiebre puede estar ausente en recién nacidos con infección grave; por ello, una temperatura normal no permite descartar sepsis. También deben activar valoración urgente:

- Enrojecimiento progresivo alrededor del cordón(12).
- Secreción purulenta o mal olor umbilical(12).
- Lesiones cutáneas extensas o pustulosas.
- Rash que no desaparece con la presión.
- Rechazo del alimento.
- Letargia, irritabilidad intensa o alteración respiratoria.
- Antecedente de infección materna o sospecha de sepsis puerperal(6).

NICE recomienda valorar al recién nacido cuando la mujer presenta sepsis puerperal confirmada o sospechada, debido a la posibilidad de infección materno-neonatal relacionada(6).

- *Alimentación, hidratación, peso y eliminación*

La alimentación deficiente es uno de los signos neonatales más sensibles a cambios del estado general. Deben activar valoración clínica urgente:

- Rechazo completo o marcado del alimento.
- Succión débil o incapacidad para sostener una toma.
- Disminución significativa de la frecuencia de alimentación.
- Somnolencia que impide alimentar al bebé.
- Vómito bilioso.

- Vómito repetido, forzado o en proyectil.
- Diarrea acompañada de signos de deshidratación.
- Disminución marcada de la orina.
- Pérdida excesiva o progresiva de peso.
- Signos simultáneos de mala alimentación, ictericia o infección.

El hallazgo de una técnica inadecuada de lactancia, sin signos de enfermedad y con buen estado general, puede manejarse inicialmente mediante apoyo domiciliario prioritario, observación de una toma y seguimiento cercano(10). En cambio, cuando la dificultad se asocia con letargia, deshidratación, dificultad respiratoria, pérdida de peso o deterioro general, debe interpretarse como posible enfermedad y no solo como una necesidad educativa.

La ausencia de expulsión de meconio durante las primeras 24 horas puede indicar una alteración grave y requiere valoración médica. Las deposiciones blancas, negras después del periodo esperado o con sangre también justifican valoración clínica. La RIA MP señala que el equipo debe indagar por alimentación, micción, deposiciones y preocupaciones de los padres y canalizar visita o atención adicional según los hallazgos(5).

- *Ictericia.*

La ictericia debe activar atención inmediata o urgente en los siguientes casos:

- Aparición durante las primeras 24 horas.
- Coloración amarilla de palmas o plantas a cualquier edad.
- Progresión rápida o ictericia intensa.
- Asociación con somnolencia, mala alimentación, hipotonía o aspecto enfermo.
- Orina oscura o deposiciones pálidas.
- Persistencia después de los periodos esperados sin causa aclarada.
- Prematuridad, hemólisis, antecedente familiar de tratamiento intensivo o condición clínica que aumente el riesgo.

La OMS considera signos de peligro la ictericia durante las primeras 24 horas y las palmas o plantas amarillas(4). NICE recomienda que la ictericia precoz se valore de inmediato y que no se estime la concentración de bilirrubina únicamente mediante inspección visual, especialmente por las dificultades de reconocimiento en tonos de piel oscuros(9). La valoración domiciliaria debe conducir a la medición institucional de bilirrubina cuando corresponda.

La educación de la familia debe indicar que la ictericia no debe manejarse exclusivamente aumentando la frecuencia de alimentación o exponiendo al bebé al sol. Estas prácticas no sustituyen la evaluación objetiva cuando existe un criterio de riesgo(9).

- *Recién nacidos que requieren seguimiento prioritario, aunque no presenten signos de alarma*

Algunos recién nacidos clínicamente estables requieren una menor tolerancia al riesgo y mayor frecuencia de seguimiento:

- Prematuros o con bajo peso al nacer.
- Recién nacidos con restricción del crecimiento.
- Antecedente de reanimación, hospitalización neonatal o complicación perinatal.
- Enfermedad congénita, metabólica, infecciosa o neurológica conocida o sospechada.
- Dificultades persistentes de alimentación.
- Pérdida de peso o ganancia insuficiente.
- Ictericia con factores de riesgo.
- Tamizajes pendientes, anormales o sin posibilidad de seguimiento.
- Tratamientos domiciliarios que requieren supervisión.
- Hijos de mujeres con infección transmisible, consumo de sustancias o enfermedad mental grave.
- Familias con barreras importantes para reconocer signos de deterioro o acceder a servicios.

La RIA MP dispone que estos recién nacidos sean clasificados según su mayor o menor riesgo, reciban atención diferencial y sean canalizados a visita domiciliaria para verificar el plan de cuidado, vigilar la alimentación, fortalecer el reconocimiento de signos de peligro y comprobar la adherencia(5).

- ***Signos de alarma y criterios de riesgo en la mujer en posparto***

- *Hemorragia posparto.*

El sangrado vaginal repentino, muy abundante, persistente o progresivo es una emergencia. También requieren valoración inmediata:

- Aumento del sangrado después de haber disminuido.
- Expulsión de coágulos grandes, tejido placentario o membranas.

- Sangrado acompañado de mareo, desmayo, palidez, debilidad intensa, taquicardia, alteración del estado de conciencia o dificultad respiratoria.
- Dolor abdominal o uterino asociado con sangrado.
- Sangrado con fiebre o loquios de olor desagradable.

La RIA M-P define la hemorragia posparto primaria por sangrado superior a 500 ml, sangrado persistente o continuo, o sangrado repentino abundante acompañado de inestabilidad hemodinámica(5). En el entorno hogar no debe esperarse una cuantificación exacta del volumen para decidir la remisión; la velocidad del sangrado, el empapamiento rápido de toallas, la presencia de coágulos y el estado general son criterios suficientes para activar urgencias.

NICE recomienda buscar atención sin demora ante sangrado súbito o muy intenso, sangrado creciente, expulsión de tejido o síntomas de infección. La anemia y el bajo peso materno pueden agravar las consecuencias de una hemorragia secundaria y deben disminuir el umbral para remitir(6).

Ante sospecha de hemorragia, el equipo debe activar la emergencia obstétrica, realizar las medidas iniciales para las cuales se encuentre capacitado, asegurar traslado medicalizado cuando la condición lo requiera y comunicar directamente al servicio receptor. La estabilización inicial no debe convertirse en una causa de demora del traslado.

En la visita domiciliaria debe indagarse activamente por factores de riesgo de hemorragia, como sangrado durante la gestación, el parto o el posparto inmediato, anemia durante la gestación, parto prolongado o instrumentado, embarazo múltiple, retención de placenta o necesidad de transfusión. Dado que la cuantificación del sangrado en mililitros es un criterio de uso clínico, en el hogar la vigilancia debe orientarse a signos observables: necesidad de cambiar una toalla empapada en una hora o menos, expulsión de coágulos grandes, sangrado que aumenta en lugar de disminuir, mareo, palidez, taquicardia o desmayo.

- *Trastornos hipertensivos, preeclampsia y compromiso neurológico.*

La preeclampsia puede aparecer o persistir durante el puerperio, incluso en mujeres sin diagnóstico hipertensivo previo. Deben activar valoración urgente:

- Cefalea intensa, persistente o diferente a la habitual.
- Edema de cara, manos o extremidades de aparición súbita o que aumenta rápidamente.
- Visión borrosa, fosfenos u otras alteraciones visuales.
- Tinnitus.
- Dolor epigástrico o en el hipocondrio derecho.

- Náuseas o vómitos persistentes, con o sin cefalea o hipertensión.
- Convulsiones.
- Confusión o alteración del estado de conciencia.
- Disnea o edema pulmonar.
- Oliguria.
- Presión arterial elevada.

La RIA M-P considera hipertensión relacionada con el embarazo una presión sistólica igual o superior a 140 mmHg o diastólica igual o superior a 90 mmHg durante las primeras cuatro semanas del puerperio. Las cifras iguales o superiores a 160/110 mmHg constituyen una crisis hipertensiva y requieren manejo inmediato(5). La presencia de cefalea, fosfenos, visión borrosa, tinnitus, epigastralgia, clonus, oliguria o compromiso cardiopulmonar indica severidad(6). En el hogar, la oliguria puede indagarse preguntando por la disminución de la frecuencia o del volumen de la orina y el compromiso cardiopulmonar por la presencia de dificultad para respirar, dolor torácico, palpitaciones o incapacidad para acostarse.

Cuando se disponga de tensiómetro, la presión arterial debe medirse con la mujer sentada, en reposo y con brazalete de tamaño adecuado. Si la cifra es igual o mayor a 140/80 mmHg, debe verificarse en el otro brazo y repetirse después de aproximadamente 10 a 15 minutos de reposo. Una cifra elevada que se confirma requiere valoración médica el mismo día; una cifra igual o mayor a 160/110 mmHg, o cualquier cifra elevada acompañada de síntomas premonitorios, requiere activación urgente de la ruta. La ausencia de tensiómetro, o una medición normal, no debe utilizarse para descartar la complicación cuando existen síntomas premonitorios (cefalea intensa o persistente, fosfenos o visión borrosa, tinnitus, epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho, náuseas o vómitos). La presencia de convulsión o alteración de conciencia exige activación inmediata de emergencia.

- *Infección puerperal y sepsis.*

Los siguientes hallazgos deben activar valoración urgente:

- Fiebre o escalofríos.
- Taquicardia, taquipnea o deterioro general.
- Dolor uterino, abdominal, pélvico o perineal.
- Loquios o secreción vaginal de olor desagradable.
- Herida quirúrgica o perineal con enrojecimiento, calor, secreción, apertura o dolor creciente.
- Dolor al orinar, dificultad miccional o síntomas urinarios acompañados de fiebre.

- Mastitis con enrojecimiento y edema que empeoran o persisten pese a medidas iniciales.
- Confusión, somnolencia o signos de choque.

NICE recomienda considerar como potencialmente grave la asociación de dolor abdominal, pélvico o perineal, fiebre, escalofríos o flujo vaginal maloliente(6). La RIA M-P señala como indicadores tempranos de infección puerperal la fiebre, taquicardia, taquipnea, subinvolución uterina, hipersensibilidad uterina y loquios fétidos(5).

La sospecha de sepsis exige remisión urgente. Además, debe evaluarse al recién nacido por posible infección, evitando manejar a la mujer y al bebé como eventos independientes.

- *Tromboembolismo y compromiso cardiopulmonar.*

La aparición de cualquiera de los siguientes síntomas debe activar atención inmediata:

- Dificultad respiratoria súbita o progresiva.
- Dolor torácico.
- Taquicardia asociada con disnea o dolor.
- Dolor, edema, calor o sensibilidad unilateral de una pierna, dificultad para caminar o dolor que no cede con el reposo.
- Tos con sangre.
- Desmayo o colapso.
- Saturación de oxígeno baja cuando pueda medirse.

NICE considera la hinchazón y sensibilidad de una pierna, la disnea y el dolor torácico signos potenciales de tromboembolismo venoso o compromiso cardiaco(6). La RIA M-P recomienda reevaluar el riesgo tromboembólico en el puerperio mediante la herramienta de valoración prevista en sus anexos e informar sobre la necesidad de acudir a urgencias ante estos signos(5).

En estos casos no se recomienda que la mujer se traslade sola ni que permanezca en observación domiciliaria. El equipo debe organizar una respuesta segura, considerando que el puerperio incrementa el riesgo de eventos tromboembólicos.

- *Heridas, dolor y problemas mamarios.*

Requieren valoración el mismo día o urgente, según la gravedad:

- Apertura de una herida perineal o quirúrgica.
- Dolor que aumenta o no responde al tratamiento indicado.
- Necesidad creciente de analgésicos.
- Hinchazón o secreción maloliente.
- Enrojecimiento que se extiende.

- Dolor mamario intenso, fiebre o compromiso general.
- Enrojecimiento y edema mamario que persisten más de 24 horas pese al manejo inicial.

NICE recomienda remitir urgentemente a servicios de maternidad ante apertura de una herida perineal y realizar valoración el mismo día(6). Los problemas mamarios leves pueden recibir apoyo inicial para la alimentación, extracción y alivio de la congestión. Sin embargo, la persistencia, el empeoramiento, la fiebre o el deterioro sistémico requieren valoración clínica para descartar mastitis complicada o absceso(10).

- ***Salud mental, conducta y capacidad para el cuidado.***

La valoración de la salud mental no debe limitarse a la aplicación de un cuestionario. La OMS recomienda preguntar por el bienestar emocional en cada contacto y utilizar instrumentos validados como EPDS o PHQ-9, siempre acompañados por mecanismos de confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento. La evidencia sobre tamizaje favorable proviene de programas en los que los resultados positivos estaban vinculados con evaluación clínica e intervención, no de la aplicación aislada de la escala(4).

- *Criterios de emergencia en salud mental.*

Deben activar de inmediato la ruta de urgencias y salud mental:

- Ideación, plan o intento de suicidio.
- Respuesta positiva al ítem de autolesión de la EPDS.
- Ideas de hacer daño al recién nacido o a otra persona.
- Alucinaciones, delirios, desorganización grave o sospecha de psicosis posparto.
- Agitación intensa, conducta impredecible o confusión.
- Episodio maniforme grave (euforia o irritabilidad marcadas, disminución de la necesidad de dormir, aceleración del pensamiento o del habla, ideas grandiosas o conductas desorganizadas o de riesgo).
- Incapacidad para reconocer necesidades básicas propias o del recién nacido.
- Abandono del cuidado asociado con deterioro mental agudo.
- Intoxicación o abstinencia que comprometa el juicio o la seguridad.

En estos escenarios, el equipo no debe dejar sola a la mujer ni al recién nacido. Debe garantizar la presencia de un adulto protector, retirar

medios de daño cuando sea posible y seguro, activar atención urgente y comunicar explícitamente el riesgo al servicio receptor(4,6).

- *Criterios de seguimiento prioritario.*

Requieren valoración diagnóstica y seguimiento cercano:

- Tamizaje positivo para depresión o ansiedad sin riesgo inmediato.
- Tristeza persistente, desesperanza, culpa o anhedonia.
- Ansiedad intensa, crisis de pánico o pensamientos intrusivos.
- Alteración significativa del sueño no explicada únicamente por el cuidado neonatal.
- Dificultad para vincularse con el recién nacido.
- Estado de ánimo que impide las actividades habituales o el cuidado.
- Antecedente de depresión, trastorno bipolar, psicosis o intento de suicidio.
- Violencia de pareja, adolescencia, pobreza o bajo apoyo social.
- Duelo, parto traumático o complicación materna o neonatal grave.

La RIA M-P indica acompañamiento por psicología y psiquiatría cuando las preguntas iniciales sugieren depresión, y seguimiento por salud mental ante puntuaciones elevadas en la EPDS(5). El lineamiento PICF clasifica el riesgo en salud mental y las mujeres en posparto como condiciones que pueden requerir cuidado especial dirigido o asistido mediante visita en dupla(11).

- ***Criterios familiares, psicosociales y de protección.***

- *Violencia, abuso, negligencia y abandono*

Debe activarse una ruta de protección y, cuando exista peligro inmediato, una respuesta de emergencia ante:

- Violencia física, sexual o psicológica actual.
- Amenazas contra la mujer o el recién nacido.
- Control coercitivo que impida buscar atención.
- Sospecha de maltrato o negligencia grave.
- Abandono del recién nacido.
- Ausencia de un adulto capaz de garantizar cuidado y protección.
- Cuidador principal gravemente intoxicado, psicótico o incapacitado.

- Exposición del recién nacido a violencia intrafamiliar.
- Privación deliberada de alimento, atención sanitaria o condiciones básicas.
- Riesgo de explotación, trata o violencia sexual, caso en el cual debe activarse la ruta de atención integral a víctimas de violencias, conforme a la Resolución 459 de 2012 o las normas que la modifiquen o sustituyan.
- Temor expresado por la mujer de regresar o permanecer en el hogar.

La indagación debe realizarse, cuando sea posible, en privacidad y sin la presencia de la persona potencialmente agresora. La seguridad de la mujer y del recién nacido prevalece sobre la concertación ordinaria de compromisos familiares(8).

La USPSTF identifica como factores asociados con maltrato la disfunción y violencia familiar, consumo de sustancias, estrés parental, antecedentes de maltrato, relaciones negativas, aislamiento social, pobreza y limitadas capacidades parentales. Sin embargo, concluye que la evidencia es insuficiente para utilizar estos factores o un instrumento universal como predictores determinantes de maltrato. Por consiguiente, los factores de vulnerabilidad deben desencadenar una valoración más profunda, pero no justifican etiquetar automáticamente a una familia como negligente o maltratante(8).

- *Incapacidad o insuficiencia familiar para sostener el cuidado*

Requieren seguimiento prioritario y posible intervención intersectorial:

- La mujer que no cuenta con apoyo para descansar, alimentarse o acudir a controles.
- El cuidador que no reconoce signos de alarma ni sabe cómo activar atención.
- Cuando existen dificultades graves para alimentar, asear o mantener seguro al recién nacido.
- Hay sobrecarga intensa, agotamiento o conflicto entre cuidadores.
- No existe una persona que pueda acompañar una urgencia.
- La familia presenta interacciones negativas o rechazo persistente hacia el recién nacido.
- Existen dificultades cognitivas, físicas o de comunicación que impiden seguir el plan de cuidado.
- Hay pérdida reciente de la persona que ejercía el apoyo principal.
- El funcionamiento familiar se deteriora rápidamente después del nacimiento.

Estos hallazgos no siempre requieren una remisión clínica inmediata, pero sí deben modificar la intensidad del PICF. Pueden justificar visita en dupla, participación de trabajo social, psicología o enfermería, concertación de un relevo para el cuidado, inclusión de la familia extensa y seguimiento antes del intervalo ordinario establecido(11).

El PICF permite omitir el intervalo mínimo habitual entre visitas cuando el riesgo o la vulnerabilidad familiar lo ameritan y contempla cuidado especial dirigido o asistido para mujeres en posparto, recién nacidos con bajo peso y familias con riesgo en salud mental(11).

- *Consumo de alcohol y otras sustancias.*

Debe activarse respuesta clínica, de salud mental, protección o tratamiento de consumo cuando:

- La mujer o el cuidador presenta intoxicación durante el cuidado.
- El consumo interfiere con la alimentación, vigilancia o seguridad del recién nacido.
- Se comparte cama con el bebé después de consumir alcohol, sedantes o sustancias.
- Existen síntomas de abstinencia o deterioro mental.
- El recién nacido pudo estar expuesto y presenta temblores, irritabilidad, alteraciones de alimentación o dificultad respiratoria.
- Hay violencia, abandono o riesgo de accidentes asociados con el consumo.
- No existe otro cuidador seguro.

En ausencia de peligro inmediato, el consumo problemático requiere intervención breve, valoración diagnóstica, seguimiento y vinculación con la ruta de salud mental o consumo de sustancias. Cuando existe amenaza para la seguridad del recién nacido, debe activarse simultáneamente la ruta de protección.

- *Pobreza, aislamiento e inseguridad alimentaria*

La pobreza, la ruralidad o la maternidad adolescente no constituyen por sí mismas evidencia de negligencia. Sin embargo, requieren respuesta intersectorial cuando se traducen en imposibilidad concreta para:

- Garantizar alimentos a la mujer o alimentación segura del recién nacido.
- Obtener agua segura.
- Mantener condiciones mínimas de abrigo e higiene.
- Comprar o recibir medicamentos prescritos.
- Asistir a controles.

- Disponer de transporte para una urgencia.
- Contar con un lugar seguro para dormir.
- Acceder a documentación, afiliación o prestaciones sociales.

El equipo debe canalizar a programas de alimentación, protección social, transporte, vivienda, documentación, apoyo a la maternidad u otros servicios municipales, y verificar que la canalización produzca acceso real(5). El PICF establece que la activación debe apoyarse en una oferta institucional concreta y actualizada, y que las familias vulnerables deben contar con acceso facilitado a servicios clínicos, sociales, educativos y económicos(11).

- ***Criterios ambientales y territoriales.***

- *Riesgos inmediatos del hogar*

Una condición ambiental debe activar respuesta urgente cuando representa un peligro inminente para la mujer o el recién nacido, por ejemplo:

- Violencia activa o presencia de armas y amenazas.
- Riesgo estructural de colapso, incendio o inundación.
- Exposición extrema a frío o calor sin posibilidad de protección.
- Humo intenso, gases, sustancias tóxicas o intoxicación.
- Ausencia total de un lugar seguro para el recién nacido.
- Animales o personas que representen una amenaza inmediata.
- Falta absoluta de agua o condiciones mínimas que impidan alimentar o cuidar con seguridad.
- Prácticas de sueño con riesgo inmediato, especialmente asociadas con intoxicación, sedación o agotamiento extremo del cuidador.

Cuando el riesgo pueda corregirse durante la visita —por ejemplo, retirar almohadas, cobijas pesadas u objetos de la cuna— debe realizarse educación y demostración inmediata. Cuando la familia no puede modificarlo por falta de recursos, debe activarse apoyo institucional o social.

- *Riesgos que justifican seguimiento prioritario*

De acuerdo con la evidencia recabada las siguientes condiciones requieren intervención y verificación:

- Colecho en condiciones inseguras.
- Superficie blanda o inclinada para dormir.

- Exposición al humo de tabaco.
- Hacinamiento severo.
- Ventilación o temperatura inadecuadas.
- Agua no segura.
- Aplicación de sustancias potencialmente dañinas al cordón.
- Almacenamiento inseguro de medicamentos o sustancias.
- Dificultades para lavarse las manos o preparar alimentos.
- Presencia de roedores, vectores o contaminación.
- Barreras arquitectónicas que dificultan el cuidado o el traslado de la mujer.

La conducta debe incluir corrección educativa, concertación de compromisos, entrega o gestión de recursos cuando sea posible y nueva observación del entorno en una visita posterior.

- *Barreras geográficas y de acceso como modificadoras de la urgencia.*

La distancia, falta de transporte, ausencia de señal telefónica, dispersión rural, inseguridad, desplazamiento o interrupción de servicios no son solamente variables administrativas. Pueden transformar una condición moderada en una situación de alto riesgo porque aumentan el tiempo hasta la atención.

La revisión de Moutwakil muestra que la inseguridad, las restricciones al movimiento, la violencia contra establecimientos y trabajadores, el desplazamiento y las fallas de comunicación deterioran el acceso y la calidad del cuidado neonatal(7). Aunque estos hallazgos provienen de contextos de conflicto y su aplicabilidad es indirecta, respaldan que en la visita familiar en el entorno hogar incorpore explícitamente la factibilidad del traslado y la capacidad real del sistema para responder.

En familias con acceso difícil, el equipo debe:

- Anticipar el transporte.
- Identificar rutas alternas.
- Definir quién acompañará a la mujer o al recién nacido.
- Entregar números y puntos concretos de atención.
- Coordinar directamente con la ESE o asegurador.
- Aumentar la frecuencia de seguimiento.
- Evitar que una remisión dependa exclusivamente de la iniciativa familiar.

- *Activación de rutas*

La continuidad no se garantiza con la emisión de una orden. La OMS establece que el modelo posnatal requiere relaciones funcionales entre los

equipos comunitarios y los servicios, comunicación entre niveles y articulación con los sistemas de transporte(4). También señala la necesidad de protocolos, ayudas de trabajo, supervisión y enlaces eficaces entre comunidad, nivel primario y servicios de mayor complejidad(4).

La RIA M-P dispone que las complicaciones maternas y neonatales sean identificadas, estabilizadas dentro de la capacidad disponible y remitidas a una institución con capacidad resolutiva, garantizando el ingreso al servicio receptor. También exige referencia y contrarreferencia y continuidad entre la ruta materno-perinatal y la ruta de promoción y mantenimiento de la salud para la primera infancia(5). Desde el PICF, los equipos deben conocer previamente la red prestadora del territorio y los mecanismos de activación de rutas; el primer punto de atención debe ser la IPS más cercana al lugar de residencia, y las personas en situación de urgencia o emergencia deben ser trasladadas, en lo posible, en transporte asistencial gestionado desde dicha IPS.

En el PICF, el paso "activar y acompañar" comprende activación de rutas integrales, canalización a programas sociales, agenda efectiva de citas y acompañamiento en el cumplimiento de los compromisos. El seguimiento debe mantener contacto con la familia, actualizar el riesgo y comprobar el resultado de las derivaciones(11).

Por tanto, ante un criterio de activación, el equipo debe documentar:

- Hallazgo objetivo y hora de identificación.
- Clasificación de la urgencia.
- Conducta inicial realizada.
- Servicio o sector activado.
- Nombre o cargo de la persona que recibe la comunicación.
- Medio y condiciones de traslado.
- Persona que acompaña a la mujer o al recién nacido.
- Confirmación de llegada y atención.
- Resultado clínico o social comunicado al equipo.
- Plan de seguimiento y fecha del próximo contacto.

Cuando una familia se niega a una remisión, el equipo debe explorar las razones, comunicar el riesgo de manera comprensible, resolver barreras evitables, documentar la decisión y aplicar los procedimientos institucionales de protección cuando la negativa pueda producir daño grave al recién nacido o a una persona sin capacidad de protegerse.

En términos generales, la evidencia respalda que toda activación se base en la gravedad clínica, la capacidad familiar para responder y las condiciones reales de acceso. Los signos neonatales de compromiso respiratorio, neurológico, térmico, infeccioso, alimentario o de ictericia

grave y los signos maternos de hemorragia, trastorno hipertensivo, infección, tromboembolismo o deterioro mental deben activar atención sin demora. La violencia, el riesgo de autolesión, la desprotección y la ausencia de un cuidador seguro requieren respuestas simultáneas del equipo interprofesional y protección.

Los factores sociales y ambientales no deben tratarse como antecedentes secundarios, se deben activar procesos de cambio en la modalidad de cuidado y de activación de rutas cuando impiden alimentar, proteger o trasladar a la mujer o al recién nacido, modifican la urgencia y obligan al equipo a gestionar recursos y acompañar la ruta. En consecuencia, la responsabilidad del PICF no termina al identificar o remitir; incluye comunicar, facilitar el acceso, confirmar la atención, recibir la contrarreferencia y actualizar el plan familiar hasta que el riesgo se resuelva o se encuentre bajo seguimiento efectivo.

8.4 Pregunta 4.

En familias con recién nacidos y mujeres en posparto atendidas mediante visitas sucesivas en el entorno hogar, ¿qué estrategias educativas, participativas y de seguimiento favorecen la agencia de cuidado familiar, y cómo debe monitorearse su implementación durante el ciclo de cuidado del PICF?

La evidencia revisada no identifica una intervención única ni un instrumento universal que, por sí solo, produzca o mida la agencia de cuidado familiar en el posparto. Sin embargo, existe una convergencia consistente entre las guías posnatales, las recomendaciones sobre lactancia y cuidado centrado en la familia, la RIA M-P y el marco operativo del PICF, que permite establecer que la agencia se favorece cuando las familias participan activamente en la comprensión de sus necesidades, practican habilidades concretas en su propio hogar, toman decisiones informadas, acuerdan responsabilidades alcanzables, movilizan sus redes y recursos, y reciben acompañamiento continuado para resolver dificultades y sostener los cambios.

En el PICF, la agencia de cuidado no debe entenderse únicamente como la adquisición de conocimientos ni como el cumplimiento pasivo de indicaciones profesionales. Se refiere a la capacidad de la mujer, los cuidadores y la familia para reconocer necesidades y riesgos, decidir de manera informada, organizarse, ejecutar prácticas seguras, buscar ayuda oportunamente y movilizar recursos propios, comunitarios e

institucionales para proteger la salud de la mujer y del recién nacido. El lineamiento departamental plantea que las familias no son receptoras pasivas de apoyo, sino participantes activas en la gestión de su bienestar; por ello, los compromisos de cuidado deben construirse mediante interacción y consenso, reconociendo lo que la familia comprende, puede, necesita y desea transformar(11).

La evidencia respalda especialmente un modelo de intervención caracterizado por:

- ✓ educación dialogada, individualizada y basada en las necesidades observadas;
- ✓ demostración, práctica y retroalimentación de habilidades;
- ✓ participación activa de la mujer, el padre y de la red de cuidado elegida por ella;
- ✓ apoyo directo a la lactancia y a otras prácticas de cuidado neonatal;
- ✓ fortalecimiento del vínculo y del cuidado sensible;
- ✓ apoyo emocional y solución conjunta de problemas;
- ✓ concertación de compromisos concretos;
- ✓ registros disponibles en el hogar;
- ✓ contactos sucesivos presenciales complementados, cuando corresponda, por seguimiento remoto;
- ✓ articulación con servicios de salud, protección y apoyo social;
- ✓ monitoreo de capacidades y prácticas demostradas, y no solamente del número de visitas realizadas.

La visita domiciliaria constituye el escenario privilegiado para estas acciones porque permite trabajar sobre las prácticas tal como ocurren en la cotidianidad. El equipo puede observar cómo se alimenta al recién nacido, dónde y cómo duerme, cómo se distribuyen las tareas, qué apoyos tiene la mujer, qué barreras enfrenta la familia y qué recursos materiales, relacionales y comunitarios puede movilizar. La OMS señala que las mujeres valoran especialmente el apoyo práctico, emocional y psicosocial en el hogar, así como la disponibilidad de diferentes formas de contacto y la continuidad con profesionales que conocen sus circunstancias(4).

- ***Educación para la salud orientada al desarrollo de capacidades.***

La educación que favorece la agencia debe partir de una valoración previa de conocimientos, experiencias, prácticas, creencias, prioridades y dificultades familiares. No se trata de entregar el mismo listado de recomendaciones a todas las familias, sino de seleccionar los contenidos pertinentes para el momento posnatal, el nivel de riesgo y los problemas observados.

La RIA M-P concibe la educación para la salud como una intervención destinada a fortalecer vínculos, redes y relaciones de cuidado y a desarrollar capacidades familiares para atender a la mujer y al recién nacido. Esto incluye conocer sus necesidades, reconocer signos de peligro, comunicarse, proporcionar apoyo y promover una participación responsable de la pareja y de la red cercana. La familia se entiende como una red primaria de cuidado que puede incluir, además de vínculos de consanguinidad, amistades, vecinos y referentes culturales o comunitarios(5).

La educación debe adoptar una metodología práctica, con los siguientes pasos:

1. Explorar lo que la familia ya sabe y hace: Preguntar por cómo está realizando el cuidado, qué ha funcionado, qué le preocupa y qué indicaciones ha recibido.
2. Reconocer las prácticas adecuadas y las capacidades existentes: Este reconocimiento evita una relación centrada exclusivamente en errores y fortalece la confianza para aprender.
3. Priorizar una necesidad concreta: En una visita no debe intentarse modificar simultáneamente todas las prácticas. Deben abordarse primero aquellas relacionadas con seguridad, alimentación, salud materna o riesgos identificados.
4. Explicar el fundamento de la recomendación: La información debe ser breve, comprensible, respetuosa y adaptada al lenguaje y contexto cultural de la familia.
5. Demostrar la práctica: Por ejemplo, postura y agarre para lactar, posición segura para dormir, cuidado del cordón, toma de temperatura o preparación para una consulta urgente.
6. Permitir que la familia la realice: La agencia se fortalece cuando el cuidador ejecuta la práctica, recibe retroalimentación y adquiere confianza, no cuando observa pasivamente al profesional.
7. Verificar comprensión y capacidad: Es útil pedir a la familia que explique o muestre qué hará, en vez de preguntar únicamente si entendió.
8. Concertar una acción para el periodo entre visitas: El establecimiento de compromisos debe indicar qué se realizará, quién será responsable, con qué apoyo y cómo se verificará.

NICE recomienda proporcionar información individualizada, sensible, consistente y basada en evidencia, utilizando formatos presenciales, escritos, digitales o accesibles según las necesidades. El profesional debe comprobar que la mujer comprendió la información y darle oportunidades suficientes para expresar dudas y preocupaciones(6).

La educación debe evitar mensajes culpabilizantes, especialmente en asuntos como lactancia, salud mental, organización del hogar o asistencia a controles. La información que desconoce las condiciones materiales, la autonomía de la mujer o las barreras estructurales puede aumentar culpa y ansiedad sin producir cambios sostenibles. En consecuencia, el equipo debe diferenciar entre una práctica que la familia no comprende, una que aún no sabe realizar y una que no puede implementar por falta de recursos o apoyo(13).

- ***Aprendizaje basado en demostración y práctica en el hogar.***

La posibilidad de observar y practicar en el contexto real es uno de los principales aportes del entorno hogar. El equipo no solo pregunta si una práctica se cumple, sino que verifica cómo ocurre y acompaña su ajuste.

Entre las habilidades que pueden ser observadas y fortalecidas se encuentran:

- Posición, agarre, succión y deglución durante la lactancia.
- Extracción y conservación de leche cuando esté indicada.
- Reconocimiento de señales de hambre y saciedad.
- Cuidado limpio y seco del cordón.
- Higiene de manos.
- Ubicación segura del recién nacido para dormir.
- Contacto piel a piel y mantenimiento de la temperatura.
- Identificación de ictericia y signos de peligro.
- Administración correcta de tratamientos prescritos.
- Preparación del traslado y activación de servicios
- Apoyo de la familia a la recuperación y descanso de la mujer.

La consejería estructurada sobre lactancia constituye el ejemplo con evidencia más clara de este enfoque. La USPSTF concluye, con certeza moderada, que las intervenciones conductuales mejoran la iniciación, duración y exclusividad de la lactancia. Estas intervenciones incluyen educación formal, enseñanza de habilidades, observación directa de una toma, ayuda con postura y agarre, apoyo psicológico, resolución de problemas y participación de familiares. Los programas desarrollados en más de un momento del continuo prenatal, perinatal y posnatal tienden a producir mejores efectos que los contactos únicos(10).

- ***Participación activa en la planificación y toma de decisiones.***

Las intervenciones centradas en la familia se sustentan en una alianza entre profesionales, mujer, padres y cuidadores. Sus elementos comunes son respeto, intercambio de información, presencia, participación en los cuidados, colaboración y participación en decisiones. La revisión de

Kocakabak y colaboradores señala que el cuidado centrado en la familia se basa en asociaciones mutuamente beneficiosas y que las intervenciones suelen incorporar presencia parental, participación en el cuidado y toma de decisiones(13).

Aunque la mayoría de los estudios incluidos en esa revisión se realizó en unidades neonatales, sus principios son transferibles al hogar. El profesional debe dejar de ocupar el lugar de quien define unilateralmente todo el plan y asumir un papel de facilitador quepresente alternativas seguras; escuche preferencias y preocupaciones; ayude a reconocer riesgos; identifique recursos familiares;

negocia metas realistas;

acuerda responsabilidades;

facilita conexiones con la red;

acompaña y revisa los resultados.

La participación debe respetar especialmente la autonomía de la mujer. La OMS recomienda involucrar a hombres y otras personas de apoyo para mejorar el autocuidado materno, las prácticas domiciliarias y la búsqueda oportuna de atención, pero condiciona esta intervención a que respete las decisiones de la mujer y no limite su autonomía(4).

- ***Concertación de compromisos familiares.***

La transformación de la información en acción requiere compromisos específicos. En el PICF, estos compromisos deben entenderse como acuerdos dialógicos y no como tareas impuestas. Su función es ayudar a la familia a transitar desde el reconocimiento de una necesidad hasta la incorporación sostenible de una práctica.

Un compromiso adecuado debe ser:

- ✓ Relevante para un riesgo o necesidad identificada.
- ✓ Comprensible para la familia.
- ✓ Específico y observable.
- ✓ Viable con los recursos disponibles.
- ✓ Asignado a una persona o conjunto de personas.
- ✓ Limitado en el tiempo.
- ✓ Verificable en la siguiente visita.
- ✓ Susceptible de modificación cuando cambien las circunstancias.

Por ejemplo, "mejorar el cuidado del recién nacido" es demasiado general. Un compromiso más útil sería: "Durante esta semana, el padre preparará el espacio seguro para dormir antes de las 8:00 p. m.; la abuela apoyará

la preparación de alimentos de la mujer; y la madre o el cuidador se comunicará con el equipo si el recién nacido rechaza dos tomas consecutivas".

El lineamiento PICF plantea que los compromisos deben registrarse en la cartilla o programador familiar para facilitar el recuerdo y el automonitoreo. En las visitas posteriores se retoman los hallazgos y acuerdos registrados en SIBACOM PLUS, se actualiza el riesgo, se valora la capacidad de agencia alcanzada y se refuerzan las actividades educativas que aún lo requieran(11).

- ***Organización de la red familiar de cuidado***

La llegada de un recién nacido transforma la distribución del tiempo, el descanso, las responsabilidades domésticas y la capacidad de la mujer para recuperarse. La agencia familiar implica que estas responsabilidades se hagan explícitas y no recaigan automáticamente sobre la mujer.

Durante la visita, el equipo debe ayudar a identificar:

- quién cuida principalmente al recién nacido;
- quién puede relevar a la mujer;
- quién prepara alimentos y realiza tareas domésticas;
- quién acompaña a los controles;
- quién puede trasladar a la mujer o al bebé en una urgencia;
- quién puede apoyar durante la noche;
- qué familiares o vecinos están disponibles;
- qué recursos comunitarios pueden activarse.

La participación de la familia debe traducirse en apoyo práctico y no solo en presencia. Puede incluir facilitar el descanso, proteger el tiempo para alimentar al recién nacido, reducir la carga doméstica, acompañar la búsqueda de atención y respetar las decisiones de la mujer(6).

La RIA M-P propone fortalecer los vínculos inmediatos de cuidado presentes en la familia, el vecindario, el barrio o la vereda y desarrollar capacidades de comunicación, apoyo y paternidad responsable (5).

- ***Cuidado sensible, vínculo y lectura de las señales del recién nacido.***

La agencia incluye la capacidad de interpretar y responder a las señales del recién nacido. La OMS recomienda apoyar a padres y cuidadores para proporcionar cuidado responsivo, actividades tempranas de aprendizaje y una interacción sensible desde el nacimiento. El cuidado responsivo supone reconocer señales de hambre, saciedad, incomodidad, cansancio

o necesidad de contacto y responder de manera oportuna, afectuosa y apropiada(4).

NICE define la alimentación responsiva como una práctica que responde a las señales del bebé y reconoce que la alimentación cumple funciones de nutrición, consuelo, afecto y seguridad. En la alimentación con leche materna o fórmula debe sostenerse al bebé, observar sus señales y evitar obligarlo a terminar una toma(6).

El equipo puede fortalecer este componente mediante:

- Observación de la interacción durante la alimentación.
- Explicación de señales de hambre y saciedad.
- Promoción de contacto piel a piel.
- Acompañamiento para calmar al bebé.
- Reconocimiento del llanto como forma de comunicación.
- Conversación y contacto visual.
- Participación de otros cuidadores.
- Prevención de prácticas bruscas o punitivas.
- Identificación de dificultades de vínculo, rechazo o agotamiento extremo.

En recién nacidos prematuros, de bajo peso o que estuvieron hospitalizados, la familia puede requerir más tiempo y acompañamiento para desarrollar confianza. La revisión de Kocakabak identificó como desenlaces relevantes la interacción padre-hijo, el apego, la participación, la autoeficacia, la preparación para el egreso, la capacidad de cuidado y el funcionamiento familiar. Sin embargo, la heterogeneidad de 97 instrumentos para 60 desenlaces impide establecer una escala única para medir estos constructos(13).

- ***Apoyo emocional, salud mental y solución de problemas***

La capacidad de cuidar puede disminuir cuando la mujer o los cuidadores presentan depresión, ansiedad, trauma, agotamiento, conflictos o ausencia de apoyo. Por ello, el fortalecimiento de la agencia requiere integrar apoyo emocional con la enseñanza de habilidades.

Las mujeres valoran la tranquilidad, el acompañamiento, la resolución de dudas y el apoyo práctico y emocional recibido durante las visitas domiciliarias. También valoran la continuidad con un profesional conocido, pues favorece la confianza y permite que el equipo comprenda mejor sus circunstancias.(6)

Las estrategias pertinentes incluyen:

- escuchar sin juzgar;
- normalizar la solicitud de ayuda;

- reconocer el agotamiento y las emociones del posparto;
- facilitar oportunidades de descanso;
- identificar personas que puedan brindar relevo;
- enseñar formas sencillas de resolver problemas;
- construir planes ante dificultades previsibles;
- realizar tamizaje cuando corresponda;
- activar atención psicológica, psiquiátrica o social;
- verificar adherencia y acceso a la ruta.

El seguimiento de la salud mental no debe reducirse al puntaje de una escala. Debe incluir funcionamiento cotidiano, capacidad para cuidar, vínculo con el recién nacido, seguridad y apoyo disponible(4).

- ***Registros domiciliarios y automonitoreo familiar.***

La OMS recomienda los registros conservados en el hogar como complemento de los registros institucionales. Estos pueden mejorar la comunicación, la búsqueda de atención, la participación de los hombres y otros cuidadores, las prácticas de cuidado en casa y la alimentación infantil(4).

Para favorecer la agencia, la cartilla o programador familiar debería contener información sencilla y accionable sobre temas como: signos de alarma maternos y neonatales; números y lugares de contacto; próximas citas y controles; vacunas y tamizajes pendientes; prácticas acordadas; responsables familiares; barreras identificadas y soluciones previstas; fecha del siguiente contacto; espacio para que la familia registre dudas, cambios y cumplimiento.

El registro debe ser comprensible y utilizable por la familia, no únicamente por el equipo. Puede incorporar símbolos, pictogramas o códigos de color en hogares con barreras de alfabetización. La información sensible, especialmente sobre violencia, salud mental o consumo de sustancias, no debe dejarse en un registro domiciliario cuando esto pueda comprometer la privacidad o seguridad.

Las comunicaciones digitales mediante llamadas, mensajes o video pueden complementar el seguimiento, especialmente en territorios rurales o dispersos. La OMS recomienda estas comunicaciones bajo condiciones de protección de datos y manejo seguro de información sensible(4).

El contacto remoto es útil para:

- recordar citas y verificar el cumplimiento de las visitas presenciales y de los compromisos acordados en contactos anteriores;
- verificar evolución;

- resolver dudas puntuales;
- reforzar compromisos;
- confirmar una remisión;
- identificar tempranamente una dificultad.

No debe sustituir la visita cuando existen problemas clínicos, dificultades de alimentación, riesgo de violencia, baja comprensión o necesidad de observar directamente el cuidado y el entorno(6). Cuando existan barreras geográficas, culturales o de disponibilidad de personal, el contacto telefónico puede ser la única oportunidad de seguimiento, por lo que debe fortalecerse y registrarse como parte del plan de cuidado, sin sustituir la valoración presencial cuando esta sea necesaria.

- ***Continuidad y visitas sucesivas.***

La agencia se construye de manera progresiva. Una visita única puede transmitir información, pero difícilmente permite observar cambios, corregir dificultades y consolidar prácticas. La OMS encontró programas con entre una y ocho visitas posnatales, realizadas entre el primer y el día 28, con frecuencia integradas a contactos prenatales(4). La evidencia no permite definir un número universal óptimo, pero respalda concentrar los contactos en las primeras semanas y adaptar su intensidad al riesgo.

El PICF concibe el seguimiento como una herramienta de continuidad. Después del primer contacto, el equipo debe mantener comunicación con la familia, establecer la periodicidad según la necesidad, designar los profesionales responsables, actualizar el riesgo y acompañar el cumplimiento de los acuerdos(11).

La continuidad se favorece cuando:

- la familia conoce quién es su profesional o equipo de referencia;
- el equipo conoce la historia y los acuerdos previos;
- se evita repetir innecesariamente las mismas preguntas;
- cada visita retoma lo trabajado anteriormente;
- las recomendaciones son coherentes entre profesionales;
- las derivaciones son verificadas;
- los nuevos hallazgos modifican el plan.

La frecuencia no debe definirse solo por una regla administrativa. Las familias con dificultades de lactancia, recién nacido prematuro o de bajo peso, depresión posparto, escaso apoyo, violencia, baja capacidad de cuidado o barreras de acceso requieren contactos más frecuentes y, en algunos casos, visitas en dupla o participación interprofesional(11).

- ***Articulación con redes y servicios***

La agencia no debe confundirse con trasladar toda la responsabilidad a la familia. Una familia puede comprender la recomendación y estar dispuesta a cumplirla, pero no contar con transporte, alimento, medicamentos, apoyo o acceso a servicios. En estos casos, la intervención debe movilizar recursos externos.

El equipo debe conocer y facilitar el acceso a: controles de puerperio y del recién nacido; apoyo a la lactancia; salud mental; nutrición; vacunación y tamizajes; trabajo social; programas de protección; apoyo alimentario; transporte; programas comunitarios y redes locales.

El lineamiento PICF establece que la continuidad implica conocer la oferta municipal, vincular a las familias con redes sociales y comunitarias y realizar seguimiento a las rutas activadas(11).

La agencia aumenta cuando la familia sabe a dónde acudir, logra acceder y adquiere experiencia para utilizar la red. Por tanto, una canalización no se considera exitosa por haber generado una orden, sino cuando se verifica que el servicio fue recibido y que la respuesta contribuyó a resolver la necesidad(4).

En términos generales, la agencia de cuidado familiar se fortalece cuando las visitas domiciliarias sucesivas pasan de un modelo de transmisión de información a un proceso de aprendizaje, participación y acompañamiento. Las estrategias con mayor sustento son la educación individualizada; la demostración y práctica de habilidades; el apoyo estructurado a la lactancia; el cuidado sensible; la participación de la red elegida por la mujer; la solución conjunta de problemas; la concertación de compromisos; el uso de registros domiciliarios; la continuidad con el equipo; y la conexión efectiva con servicios y recursos sociales.

El monitoreo debe valorar no solo cuántas visitas se realizan, sino qué componentes se entregan, qué habilidades demuestra la familia, qué prácticas cambian, qué compromisos se sostienen, qué barreras persisten y qué resultados se alcanzan. La agencia se evidencia cuando la familia puede organizar el cuidado, tomar decisiones informadas, actuar con seguridad, reconocer sus límites, pedir ayuda oportunamente y movilizar recursos sin quedar aislada ni sustituir la responsabilidad del sistema de salud.

- ***Limitaciones de la evidencia frente a la agencia de cuidado.***

La mayor parte de la evidencia utiliza desenlaces indirectamente relacionados con la agencia, como conocimientos, autoeficacia, participación, satisfacción, preparación para el egreso, lactancia o prácticas de cuidado. No se identificó una escala validada que mida de manera integral la agencia de cuidado de familias con recién nacidos en

el hogar. Además, varios estudios de cuidado centrado en la familia provienen de unidades neonatales, por lo cual su aplicabilidad al hogar debe interpretarse con cautela.

La evidencia tampoco permite definir con certeza un número óptimo de visitas para todas las familias. La intensidad debe adaptarse al riesgo, la capacidad familiar, la evolución y las barreras territoriales. La semaforización de compromisos y los logros trazadores del PICF son herramientas operativas pertinentes para el contexto departamental, pero requieren monitoreo de validez, consistencia entre equipos y relación con resultados de salud.

9. Pautas de cuidado basadas en la evidencia para familias con recién nacidos y mujeres en posparto en el entorno hogar.

Los siguientes lineamientos se derivan de la síntesis de evidencia organizada para las cuatro preguntas del documento técnico. Se formulan como orientaciones específicas, accionables y adaptables al contexto territorial. La valoración y las intervenciones del PICF deben complementar, y no sustituir, los controles clínicos, tamizajes, tratamientos y atenciones establecidos en la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal —RIAMP— y en las demás rutas aplicables.

Estas pautas se orientan desde un enfoque de cuidado centrado en la familia, que reconoce a la mujer, al recién nacido, al padre o la pareja y a otros cuidadores significativos como sujetos de cuidado y como participantes activos del plan, respetando las decisiones de la mujer y las diversas configuraciones familiares. En particular, toda condición de riesgo identificada en el recién nacido debe enrutarse de manera explícita a la RIAMP. Asimismo, las cinco primeras causas de morbilidad de la mujer en posparto y del recién nacido en el territorio deben revisarse para su articulación con las demás rutas integrales de atención aplicables.

9.1 Pautas pregunta 1. Valoración integral y estratificación del riesgo

- En toda familia con recién nacido, antes de la visita domiciliaria se recomienda identificar condiciones de riesgo y/o situaciones que requieren gestión antes o durante la visita, a partir de la historia clínica materna y neonatal, el resumen de egreso, la información disponible en SIBACOM PLUS, los reportes de vigilancia, los antecedentes familiares, los resultados de tamizajes (incluidos los de la estrategia ETMI-Plus para la eliminación de la transmisión materno-infantil del

VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas) y las remisiones pendientes. Esta preclasificación debe revisar las condiciones de la gestación y el nacimiento e identificar problemas como la prematuridad, bajo peso al nacer, restricción del crecimiento, necesidad de reanimación, hospitalización o complicación neonatal, anomalías congénitas, dificultades de alimentación, hipertensión o preeclampsia, hemorragia, infección, cirugía o enfermedad materna, morbilidad materna extrema o ingreso de la mujer a unidad de cuidado intensivo, antecedentes de salud mental, violencia, ausencia de apoyo familiar, parto domiciliario o no institucional, ausencia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, barreras de acceso y condiciones inseguras de la vivienda (1-4). Dado que la información de contacto (dirección y teléfono) y las bases de datos pueden estar desactualizadas, se recomienda que, antes del egreso, la institución verifique estos datos e informe a la familia que la visita domiciliaria hace parte del proceso de cuidado iniciado en el servicio de salud.

- El parto domiciliario o no institucional constituye una condición de riesgo para la mujer y el recién nacido. Cuando se identifique, la visita debe priorizarse y la mujer y el recién nacido deben canalizarse de inmediato a la institución de salud más cercana a su lugar de residencia para la atención del posparto y del recién nacido, la realización de los tamizajes neonatales y la vacunación.
- La morbilidad materna extrema presenta una frecuencia elevada durante el posparto; por ello, las mujeres con este antecedente durante la gestación, el parto o el puerperio deben clasificarse como de alto riesgo y recibir seguimiento prioritario, en articulación con el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna.
- Cuando la mujer o el recién nacido no se encuentren afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud, el equipo debe orientar y gestionar la afiliación ante la entidad territorial competente, sin que esta condición retrase la canalización ni la atención de los signos de alarma.
- Para los lactantes menores de seis meses con riesgo nutricional o dificultades de alimentación, y para sus madres, puede tomarse como referencia complementaria el enfoque MAMI (atención de lactantes pequeños y nutricionalmente en riesgo menores de seis meses y sus madres), desarrollado inicialmente para contextos de crisis humanitaria. Este enfoque integra la valoración conjunta de la díada y el cuidado responsivo, entendido como la capacidad de la madre y de los cuidadores de reconocer e interpretar las señales del recién nacido y de responder a ellas de manera oportuna y afectuosa.

- Cuando la preclasificación identifique condiciones que aumenten el riesgo o comprometan la continuidad del cuidado por factores maternos, neonatales, familiares, psicosociales, ambientales o de acceso, se recomienda priorizar la visita domiciliaria, seleccionar el perfil profesional o la dupla requerida y orientar la valoración hacia los riesgos, necesidades y situaciones que requieren atención. La ausencia de información clínica, resultados de tamizajes o plan de seguimiento debe considerarse una alerta para la continuidad y debe generar gestión directa con el prestador, asegurador o servicio correspondiente. La presencia de un factor de riesgo no determina por sí sola la intensidad de la respuesta: las condiciones como la prematuridad o el bajo peso al nacer requieren seguimiento prioritario, mientras que los signos de compromiso vital requieren respuesta inmediata, de acuerdo con la diferenciación entre riesgo crítico, alto y habitual de este lineamiento.
- En la primera visita domiciliaria se recomienda realizar una valoración integral, modular y estructurada de la mujer, el recién nacido, los cuidadores, la familia y el entorno, incluidas, cuando sea pertinente, las interacciones de cuidado. La valoración debe combinar información clínica, familiar, psicosocial y ambiental, de acuerdo con las necesidades identificadas. No se recomienda utilizar una única escala para establecer de manera global el nivel de riesgo o la intensidad del acompañamiento, debido a que no se identificó un instrumento validado que integre de manera suficiente los componentes maternos, neonatales, familiares, psicosociales y ambientales.
- La clasificación del riesgo debe integrar cuatro fuentes de información: antecedentes clínicos y perinatales; valoración clínica breve de la mujer y el recién nacido; aplicación selectiva de instrumentos de salud mental, lactancia y funcionamiento familiar; y observación directa de las relaciones, prácticas de cuidado, condiciones del hogar y barreras de acceso. Un hallazgo grave en cualquiera de estos dominios debe prevalecer sobre la ausencia de riesgo en los demás.
- En cada visita se recomienda valorar conjuntamente a la mujer y al recién nacido, reconociendo que sus condiciones son interdependientes. La infección, hemorragia, hipertensión, dolor incapacitante o alteraciones de la salud mental de la mujer pueden interferir con la capacidad para atender las necesidades del recién nacido; de igual manera, la enfermedad, hospitalización o dificultad de alimentación del bebé pueden incrementar la carga de cuidado y afectar el bienestar emocional materno . Cuando la familia haya vivido una muerte fetal o neonatal, la visita debe ofrecer acompañamiento al duelo perinatal, valorar la recuperación física y la salud mental de la

mujer, brindar información sobre lactancia (supresión o donación) y orientar hacia los servicios de apoyo psicosocial disponibles.

- En la mujer en posparto se recomienda indagar y realizar una revisión por sistemas para verificar: estado de ánimo y bienestar emocional, sangrado vaginal, características de los loquios, dolor abdominal, uterino, perineal o quirúrgico, estado de las heridas, cefalea, alteraciones visuales, fiebre, escalofríos, micción, función intestinal, dolor o enrojecimiento mamario, dolor torácico, dificultad respiratoria, dolor o edema unilateral de una pierna, alimentación, hidratación, descanso y apoyo disponible. La valoración debe identificar signos de alarma que requieran atención inmediata y necesidades de apoyo para la recuperación física y emocional y para el cuidado del recién nacido.
- Como parte de las orientaciones sobre cuidado e higiene en el hogar, se toma como referencia la estrategia departamental "MEMO Mejores momentos", adaptada para el PICF.
- De acuerdo con las competencias del talento humano, las condiciones clínicas y la disponibilidad de equipos adecuados para la valoración de la madre y del recién nacido, se recomienda medir presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno y estado de conciencia de la mujer. La ausencia de equipos o la imposibilidad de completar la valoración no debe retrasar la remisión si existen signos clínicos de alarma. Para ello, el equipo que realiza la visita debe contar como mínimo con tensiómetro validado, fonendoscopio, termómetro y pulsioxímetro.
- Es importante verificar o preguntar por los antecedentes y resultados de tamizaje de sífilis, hepatitis B, VIH y enfermedad de Chagas durante la gestación, si se recibió tratamiento y, según el caso, que se sigan las indicaciones sobre la lactancia materna.
- La Escala Obstétrica de Alerta Temprana debe utilizarse como apoyo para organizar la interpretación de los signos vitales cuando el profesional tenga la competencia y los equipos requeridos. Puede complementarse con otros instrumentos de valoración en el hogar, y su interpretación debe orientar la activación de la ruta para la atención de la emergencia obstétrica, de acuerdo con el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna. La escala cuenta con aplicación por profesionales de enfermería en el ámbito institucional; en el hogar, cualquier signo vital alterado requiere valoración institucional, independientemente del puntaje obtenido.
- En todos los contactos posnatales se recomienda explorar el bienestar emocional de la mujer, incluyendo tristeza persistente, ansiedad, desesperanza, pérdida de interés, culpa, agotamiento extremo,

pensamientos intrusivos, deterioro funcional, dificultad para vincularse con el recién nacido, ideación suicida y síntomas psicóticos. Cuando el padre, la pareja u otro cuidador principal participe en el cuidado, se recomienda indagar también por su bienestar emocional, cansancio, ansiedad o síntomas depresivos, dado que estos pueden afectar el apoyo a la mujer y el cuidado del recién nacido, y orientarlo hacia los servicios disponibles cuando sea necesario. La salud mental materna debe abordarse de manera explícita en cada contacto, tanto en la gestación como en el posparto: se recomienda indagar activamente por el estado de ánimo, la ansiedad, el sueño, el vínculo con el recién nacido, la violencia y el apoyo disponible, y canalizar a los servicios de salud mental cuando se identifiquen signos de riesgo.

- Se recomienda la exploración y tamización de síntomas depresivos en mujeres durante el posparto, en el entorno hogar, dentro del PICF de Boyacá. La herramienta recomendada por factibilidad[2] es la PHQ-9, este instrumento tiene la ventaja de ofrecer una valoración más completa de síntomas, incluir un ítem relacionado con pensamientos de muerte o autolesión y disponer de un sistema de puntuación sencillo. No obstante, ese ítem no reemplaza una evaluación clínica del riesgo suicida; cualquier indicio debe activar la valoración de seguridad independientemente del total.
- Si la mujer presenta ideación, plan o intento de suicidio, pensamientos de hacer daño al recién nacido, alucinaciones, delirios, desorganización grave, confusión o incapacidad para garantizar el cuidado, se recomienda suspender la valoración ordinaria, no dejar sola a la mujer ni al bebé y activar de inmediato las rutas de urgencias, salud mental y protección.
- En cada visita se recomienda valorar en el recién nacido la apariencia, color, perfusión, estado de alerta, actividad, postura, tono, movimientos, respiración, temperatura, alimentación, micción, deposiciones, peso cuando sea posible, piel, cordón umbilical, ictericia, llanto y capacidad de respuesta. También se debe verificar el cumplimiento de controles, vacunación, tamizajes y tratamientos indicados.
- Se recomienda considerar como signos de peligro neonatal la alimentación inadecuada, convulsiones, frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto, tiraje torácico severo, ausencia de movimiento espontáneo, temperatura mayor de 37,5 °C o menor de 35,5 °C,

[2] Al explorar con los autores la licencia de uso de la Escala de Depresión Posnatal de Edimburgo, que es la recomendación número 1 por evidencia, se informó que se debe pagar una tarifa anual por esta licencia, aspecto que no factibiliza su uso en el departamento.

ictericia durante las primeras 24 horas o coloración amarilla de palmas y plantas. La presencia de cualquiera de estos signos requiere valoración clínica y remisión según la gravedad.

- También se recomienda valorar como posibles signos de enfermedad grave la palidez marcada, coloración cenicienta, moteada o cianótica, falta de respuesta, llanto débil o anormalmente agudo, quejido, apnea, fontanela abombada, rash que no desaparece con la presión, vómito bilioso o proyectivo, deshidratación y cambio importante del comportamiento. Baby Check puede explicarse como apoyo para que los cuidadores describan la condición del recién nacido, pero no debe sustituir el examen profesional ni utilizarse como único mecanismo para descartar enfermedad grave.
- En toda familia en la que el recién nacido reciba leche materna se recomienda observar directamente, cuando sea posible, una toma y valorar posición, agarre, succión, deglución, dolor, lesiones, frecuencia y duración de las tomas, señales de alimentación suficiente, diuresis, deposiciones, evolución del peso, uso de fórmula, otros líquidos, biberones o chupos y disponibilidad de apoyo para la mujer. Puede utilizarse la lista de chequeo de lactancia de AIEPI y el carné de salud infantil.
- Si la dificultad para alimentarse se limita a problemas de postura o agarre y el recién nacido está activo, estable, bien hidratado y sin pérdida preocupante de peso, se recomienda realizar consejería, corregir la técnica, observar nuevamente la toma y programar seguimiento prioritario. Si hay rechazo marcado, succión débil, somnolencia que impide alimentarlo, deshidratación, dificultad respiratoria, ictericia, pérdida excesiva de peso o deterioro general, se recomienda remitir para valoración clínica.
- En cada visita durante el periodo neonatal se recomienda observar la presencia y progresión de ictericia en piel, escleróticas y encías, preguntar por somnolencia, alimentación, orina oscura y deposiciones pálidas y revisar los factores de riesgo. No se recomienda estimar el nivel de bilirrubina únicamente mediante inspección visual ni indicar exposición al sol como tratamiento.
- Si la ictericia aparece durante las primeras 24 horas, progresa rápidamente, alcanza palmas o plantas, se acompaña de somnolencia o mala alimentación o persiste más allá del periodo esperado, se recomienda activar la atención institucional para medición objetiva de bilirrubina y valoración clínica. La bilirrubinometría y los estudios diagnósticos corresponden principalmente al ámbito institucional.

- En la valoración familiar se recomienda utilizar la ficha familiar y los módulos correspondientes de SIBACOM PLUS y, cuando sean pertinentes, el familiograma, el APGAR familiar y el ecomapa. Estos instrumentos permiten explorar estructura, relaciones, percepción de apoyo, funcionamiento familiar, vínculos con familia extensa, comunidad, servicios y otros sectores; deben interpretarse conjuntamente con la observación y el juicio profesional.
- La Escala de Zarit debe considerarse cuando exista una situación concreta de cuidado intensivo, enfermedad, dependencia o sobrecarga. No se recomienda utilizarla de manera universal en todas las familias con recién nacido ni como instrumento específico del posparto.
- No se recomienda utilizar el APGAR familiar, familiograma, ecomapa o Zarit de manera aislada para predecir complicaciones maternas o neonatales. Sus resultados deben orientar la identificación de necesidades, la movilización de redes y la formulación del plan familiar.
- Se recomienda valorar las capacidades demostradas de los cuidadores, solicitándoles que expliquen o muestren cómo alimentan, cargan, abrigan, ubican para dormir y asean al recién nacido; cómo cuidan el cordón, administran tratamientos, reconocen signos de alarma y activarían una ruta. La declaración de conocimiento no debe considerarse equivalente a la capacidad para ejecutar la práctica.
- Se recomienda identificar quién ejerce el cuidado principal, quién puede relevarlo, quién apoya la alimentación y el descanso de la mujer, quién acompaña los controles, quién dispone de transporte y qué familiares, vecinos u organizaciones pueden movilizarse. La ausencia de un cuidador seguro, la sobrecarga intensa o la imposibilidad de garantizar necesidades básicas deben aumentar la prioridad del seguimiento. Con el consentimiento de la mujer, se recomienda identificar si el padre del recién nacido u otra persona significativa convive o participa en la crianza, cuál es su disposición y disponibilidad para el cuidado y qué barreras laborales, culturales o de horario limitan su participación.
- En un espacio privado y seguro se recomienda explorar violencia de pareja o intrafamiliar, control coercitivo, consumo de alcohol u otras sustancias, aislamiento social, inseguridad alimentaria, conflictos familiares, rechazo hacia el recién nacido, incapacidad del cuidador y sospecha de maltrato, negligencia o abandono.
- La pobreza, ruralidad, edad materna, bajo nivel educativo o composición familiar no deben considerarse por sí solas evidencia de negligencia. Si estas condiciones producen imposibilidad concreta para

alimentar, proteger, cuidar o acceder a servicios, se recomienda activar apoyos sociales e intersectoriales; si existe daño, amenaza o desprotección, se debe activar la ruta de protección.

- Durante la visita se recomienda observar el lugar, superficie y posición de sueño del recién nacido, objetos presentes, exposición al humo, temperatura y ventilación, disponibilidad de agua segura, higiene, cuidado del cordón, hacinamiento, animales, vectores, almacenamiento de medicamentos o sustancias peligrosas y condiciones para el descanso y recuperación de la mujer.
- Si se identifica una práctica ambiental insegura que puede corregirse durante la visita, se recomienda realizar la modificación y demostración inmediata. Si la familia no puede modificarla por falta de recursos, se debe activar apoyo institucional o social y verificar posteriormente la respuesta.
- Se recomienda valorar la capacidad real de acceso a los servicios: distancia, transporte, recursos económicos, señal telefónica, afiliación, barreras administrativas, conocimiento de puntos y horarios de atención, persona acompañante, barreras lingüísticas, culturales o relacionadas con discapacidad. Estas condiciones deben modificar la clasificación y el umbral de remisión).
- Se sugiere clasificar como riesgo inmediato o crítico la presencia de signos de alarma maternos o neonatales, deterioro clínico, ideación suicida, psicosis, violencia o amenaza inmediata, sospecha de maltrato grave, ausencia de un cuidador seguro o peligro ambiental inminente. Este nivel requiere activación inmediata de la ruta, comunicación con el servicio receptor y verificación posterior de la atención.
- Se sugiere clasificar como riesgo alto o de seguimiento prioritario la prematuridad, bajo peso, complicación perinatal, dificultades persistentes de alimentación, ictericia con factores de riesgo, enfermedad materna o complicación obstétrica reciente, tamizaje positivo de salud mental sin peligro inmediato, apoyo familiar insuficiente, baja competencia del cuidador, violencia no inminente, inseguridad alimentaria, vivienda inadecuada o barreras graves de acceso. Este nivel requiere visitas más frecuentes, plan explícito, intervención interdisciplinaria y verificación de remisiones.
- Se sugiere clasificar como riesgo habitual con seguimiento programado a la mujer y el recién nacido clínicamente estables, con alimentación adecuada, ausencia de signos de alarma, controles y tamizajes programados, cuidadores con capacidad demostrada, red de apoyo disponible y condiciones razonablemente seguras. Esta clasificación no implica cierre del seguimiento y debe actualizarse en cada contacto.

- En cada valoración se recomienda registrar el hallazgo, nivel de riesgo, conducta realizada o acordada, responsable familiar e institucional, servicio activado, plazo, fecha del siguiente contacto y resultado de la remisión o canalización. No se recomienda registrar un riesgo sin asociarlo con una respuesta y un mecanismo de verificación.
- Cuando se identifique un riesgo inmediato, la canalización debe ser inmediata y contar con soporte documental, y la mujer o el recién nacido deben dirigirse a la institución de salud más cercana a su lugar de residencia. El registro de la canalización debe compartirse con el prestador primario para verificar que la atención se haya prestado efectivamente, en articulación con el Plan de Aceleración para la Reducción de la Mortalidad Materna. Asimismo, se recomienda fortalecer el reconocimiento comunitario de los signos de alarma.
- Se recomienda utilizar el carné materno y el carné de salud infantil como estrategia de implementación que favorezca la comunicación y la continuidad entre los entornos institucional y hogar. En cada visita, el equipo del PICF debe revisarlos, verificar las atenciones y tamizajes registrados y consignar los hallazgos, conductas y canalizaciones realizadas.

9.2 Pautas pregunta 2. Intervenciones familiares estructuradas

- En toda familia con recién nacido y mujer en posparto se recomienda ofrecer un paquete domiciliario multicomponente que incluya valoración de la mujer y del recién nacido, educación práctica, apoyo a la alimentación, prácticas esenciales de cuidado neonatal, autocuidado materno, salud mental, participación del padre, la pareja u otros cuidadores y de la red familiar, reconocimiento de signos de alarma, gestión de controles y remisiones y seguimiento de compromisos. No se recomienda reducir la intervención a una charla, entrega de material o visita sin contenidos previamente definidos.
- Se recomienda realizar el primer contacto domiciliario durante la primera semana y priorizarlo en primíparas (mujeres después de su primer parto), madres adolescentes, familias con recién nacido prematuro o de bajo peso, antecedentes maternos o neonatales de riesgo, dificultades de alimentación, síntomas de salud mental, bajo apoyo familiar o barreras geográficas, económicas o administrativas. En coherencia con la OMS, que recomienda al menos cuatro contactos posnatales (en las primeras 24 horas, entre las 48 y 72 horas, entre los 7 y 14 días y a las seis semanas), y con la RIA M-P, que establece el control del recién nacido entre el tercer y el quinto día, el número y

la periodicidad de las visitas domiciliarias deben complementar estos contactos institucionales e intensificarse según el nivel de riesgo identificado.

- La intensidad de la intervención debe adaptarse al riesgo: se recomienda un componente básico para todas las familias; un componente reforzado, con visitas más frecuentes y participación interdisciplinaria, para familias con riesgos clínicos, familiares o sociales; y un componente especializado cuando se requieran intervenciones clínicas, psicológicas, sociales o de protección que excedan la capacidad del equipo domiciliario.
- La visita domiciliaria debe utilizarse como plataforma para observar prácticas, resolver dificultades, desarrollar habilidades y conectar a la familia con los servicios. No debe asumirse que cualquier visita es efectiva por el solo hecho de realizarse en el hogar; su beneficio depende de los contenidos, competencias del personal, continuidad, supervisión y capacidad de respuesta del sistema.
- En cada intervención educativa se recomienda seleccionar los contenidos según la edad del recién nacido, riesgos identificados, preocupaciones familiares y prácticas observadas. No se recomienda abordar todos los temas con igual profundidad en una única visita ni entregar información excesiva que dificulte su comprensión.
- La educación debe incluir exploración de lo que la familia sabe y hace, reconocimiento de las prácticas adecuadas, priorización de una necesidad, explicación del fundamento, demostración, práctica por parte del cuidador, corrección respetuosa, verificación de comprensión, concertación de una acción y seguimiento en la visita posterior. Cuando la mujer lo acepte, se recomienda programar las visitas en horarios que faciliten la presencia del padre, la pareja u otros cuidadores e invitarlos a participar activamente en las demostraciones y prácticas, de modo que las habilidades de cuidado no se concentren exclusivamente en la mujer.
- Después de una orientación se recomienda pedir a la mujer o al cuidador que explique con sus propias palabras o demuestre cómo realizará la práctica. Si no puede hacerlo, el profesional debe repetir, simplificar, adaptar o dividir la enseñanza. No se recomienda considerar que una actividad educativa fue completada únicamente porque se proporcionó información.
- Los materiales educativos deben ser comprensibles, consistentes, basados en evidencia y adaptados al idioma, nivel de alfabetización, cultura, ruralidad y discapacidad. Pueden utilizarse materiales

impresos, digitales o pictográficos, siempre que complementen y no sustituyan la interacción y la práctica.

- En mujeres que han decidido amamantar y no presentan contraindicación, se recomienda proporcionar apoyo estructurado que incluya observación de una toma, corrección de postura y agarre, valoración de succión y deglución, manejo inicial de dificultades, extracción de leche cuando esté indicada, apoyo emocional, participación de la red elegida por la mujer y seguimiento posterior. El padre, la pareja u otros cuidadores pueden apoyar la lactancia facilitando el descanso y la alimentación de la mujer, asumiendo otras tareas de cuidado del recién nacido, acompañando las tomas y respaldando las decisiones de la mujer frente a presiones familiares o comerciales.
- Si se detectan dificultades de lactancia sin signos de enfermedad neonatal, se recomienda corregir la técnica, ayudar a pegar al recién nacido al seno, apoyar la extracción de leche cuando corresponda, identificar las causas familiares o contextuales y programar seguimiento cercano. Si el recién nacido no logra alimentarse o presenta rechazo, succión débil, somnolencia, deshidratación, dificultad respiratoria, pérdida excesiva de peso o deterioro general, se recomienda remitir.
- Las intervenciones de lactancia y alimentación deben comunicarse de manera respetuosa y no culpabilizante. No se recomienda utilizar mensajes que generen vergüenza, ansiedad o sensación de fracaso; cuando se requiera suplementación, se debe explicar la indicación, garantizar un método seguro y apoyar la producción de leche materna cuando sea posible.
- Se recomienda enseñar y verificar prácticas esenciales de cuidado neonatal: higiene de manos, termorregulación, contacto piel a piel cuando corresponda, cuidado limpio y seco del cordón, posición supina y superficie firme para dormir, vacunación y tamizajes, cuidado responsivo, identificación de ictericia y reconocimiento de signos de peligro. Estas prácticas deben enseñarse y verificarse también con el padre, la pareja u otros cuidadores que participen en el cuidado cotidiano, incluyendo el baño, el cambio de pañal, el consuelo del llanto, el contacto piel a piel y la preparación del espacio de sueño.
- No se recomienda aplicar sustancias caseras al cordón umbilical. Se recomienda cuidado limpio y seco; la aplicación de clorhexidina debe limitarse a los contextos y protocolos en los que se encuentre específicamente indicada.

- En recién nacidos prematuros o de bajo peso vinculados al Programa Madre Canguro se recomienda apoyar a la familia en la posición segura, continuidad del contacto piel a piel (en la que pueden participar el padre u otros cuidadores como portadores canguro), conservación de la temperatura, alimentación con leche materna, reconocimiento de deterioro y cumplimiento de controles. El PICF debe complementar y no sustituir el programa clínico especializado.
- Cuando el recién nacido egrese con oxígeno domiciliario, la visita debe verificar que la familia conozca el flujo prescrito y no lo modifique sin indicación; el uso y cuidado de la cánula, el concentrador o el cilindro; las medidas de seguridad (no fumar ni encender fuego cerca, mantener el equipo lejos de fuentes de calor y asegurar los cilindros); la disponibilidad de reserva y del contacto del proveedor; y los signos de deterioro respiratorio (aumento del esfuerzo, cianosis, pausas respiratorias o dificultad para alimentarse). Debe abordarse además la ansiedad de los cuidadores, promover el contacto piel a piel y la lactancia, y asegurar la articulación con el Programa Madre Canguro o el servicio tratante para el seguimiento y retiro del oxígeno.
- Se recomienda incluir en el plan familiar el autocuidado y recuperación de la mujer: vigilancia del sangrado, cuidado de heridas, dolor, salud mamaria, alimentación, hidratación, descanso, movilización, micción, función intestinal, anticoncepción posparto y cumplimiento del control de puerperio.
- Se recomienda garantizar espacios concretos de asesoría en planificación familiar posparto. Cuando la mujer no haya iniciado un método anticonceptivo, el equipo debe brindarle información y educación, y remitirla o canalizarla a los servicios de planificación familiar (recomendación por consenso de expertas).
- La familia debe acordar apoyos prácticos para la mujer, incluyendo relevo para el descanso, preparación de alimentos, disminución de tareas domésticas, acompañamiento a controles, apoyo a la alimentación del recién nacido y disponibilidad para el traslado en caso de urgencia. Estos apoyos deben distribuirse de manera equitativa, promoviendo la corresponsabilidad del padre o la pareja en las tareas de cuidado y domésticas, y no limitarse a una ayuda ocasional.
- En cada visita se recomienda ofrecer un componente universal de apoyo emocional que incluya escucha sin juicio, indagación sobre bienestar, reconocimiento del agotamiento, normalización de la solicitud de ayuda, fortalecimiento de la comunicación y red de apoyo y enseñanza de estrategias sencillas de afrontamiento y solución de problemas.

- Las mujeres con antecedentes de depresión, ansiedad, psicosis, violencia, parto traumático, complicación materna o neonatal o bajo apoyo deben recibir seguimiento más frecuente. Si se identifican síntomas clínicamente significativos, se recomienda canalizar a valoración y tratamiento y verificar que la atención se haya realizado.
- La aplicación de una escala de salud mental sin confirmación diagnóstica, tratamiento y seguimiento no debe considerarse una intervención suficiente. Todo resultado positivo debe vincularse con una conducta, servicio responsable y plazo de respuesta.
- Se recomienda involucrar a la pareja, padre del bebé, familiares, amistades o vecinos únicamente cuando sean personas elegidas por la mujer y constituyan apoyos seguros. Su participación debe traducirse en responsabilidades concretas y no limitar la autonomía ni reforzar relaciones de control. Cuando la mujer lo autorice, se recomienda reconocer al padre o la pareja como cuidador y no solo como apoyo de la mujer, explorar sus conocimientos, preocupaciones y expectativas, y orientarlo sobre la licencia de paternidad y otros derechos que faciliten su participación en el cuidado.
- Si se identifica violencia, control coercitivo o temor hacia la pareja, no se recomienda promover su participación ordinaria en el plan de cuidado sin una valoración de seguridad; se debe priorizar la protección de la mujer y del recién nacido y activar la ruta intersectorial de atención a violencias, la cual suele iniciar con la atención en salud en la IPS más cercana, comisaría de familia y notificación al ICBF cuando se involucren niños, niñas o adolescentes.
- Se recomienda utilizar registros disponibles en el hogar que incluyan signos de alarma, datos de contacto, citas, vacunas y tamizajes, prácticas acordadas, responsables familiares, remisiones y fecha del siguiente contacto. La información sensible sobre violencia, consumo o salud mental no debe quedar expuesta si puede comprometer la seguridad.
- Las llamadas, mensajes o videollamadas pueden utilizarse para recordar citas, resolver dudas, verificar evolución, reforzar prácticas y confirmar remisiones. No deben sustituir la visita presencial cuando existen signos de alarma, dificultades importantes de alimentación, riesgo psicosocial o necesidad de observar directamente el entorno .
- Las acciones educativas y de promoción pueden compartirse con auxiliares de enfermería o trabajadores comunitarios entrenados, siempre que se definan sus competencias, exista capacitación práctica, supervisión, protocolos, posibilidad de consulta con profesionales y

mecanismos de remisión. No se recomienda delegar diagnóstico o manejo clínico a personal sin competencia para realizarlo.

- Se recomienda estandarizar los contenidos mínimos, los signos de alarma, las habilidades que deben demostrarse, los criterios de remisión, el registro y los resultados a monitorear; la frecuencia, duración y composición del equipo deben adaptarse al riesgo, condiciones familiares y características territoriales.

9.3 Pautas pregunta 3. Criterios de alarma y activación de rutas

1. En cada contacto se recomienda preguntar a la familia si ha observado cambios en la alimentación, respiración, color, temperatura, comportamiento, eliminación o capacidad de respuesta del recién nacido. La preocupación persistente de los cuidadores debe tomarse en serio y debe disminuir el umbral para realizar valoración ampliada o remitir, aunque inicialmente no se identifique un signo aislado concluyente.
2. Si se identifica un signo de compromiso vital, deterioro clínico, riesgo de autolesión, violencia, desprotección grave o incapacidad para garantizar el cuidado, se recomienda activar inmediatamente la ruta correspondiente. No se debe esperar a completar escalas, instrumentos familiares, actividades educativas o la totalidad de la visita.
3. Se recomienda diferenciar cuatro tipos de respuesta: emergencia o atención inmediata; valoración clínica urgente o el mismo día; seguimiento domiciliario prioritario; y respuesta intersectorial con seguimiento continuado. Una familia puede requerir simultáneamente más de una respuesta.
4. Si el recién nacido no responde, es difícil de despertar, no presenta movimientos espontáneos, tiene convulsiones, hipotonía intensa, llanto débil o anormalmente agudo, fontanela abombada, palidez marcada, color ceniciento, moteado o cianosis o parece gravemente enfermo, se recomienda activar atención inmediata, comunicar al servicio receptor y organizar traslado. No se recomienda mantenerlo en observación domiciliaria.
5. Si el recién nacido presenta frecuencia respiratoria mayor de 60 por minuto, tiraje torácico marcado, quejido, apnea, cianosis central, dificultad respiratoria creciente o fatiga que interrumpe la alimentación, se recomienda activar urgencias. La ausencia de

oxímetro no debe retrasar la remisión frente a signos clínicos evidentes.

6. Si la temperatura del recién nacido es mayor de 37,5 °C o menor de 35,5 °C, se recomienda valoración clínica urgente, especialmente si se acompaña de mala alimentación, letargia, cambios respiratorios, coloración anormal o deterioro general. Una temperatura normal no descarta infección grave.
7. Si se identifica enrojecimiento progresivo alrededor del cordón, secreción purulenta, mal olor, lesiones cutáneas extensas, rash que no desaparece con la presión, rechazo del alimento, letargia, irritabilidad intensa o alteración respiratoria, se recomienda valoración urgente por posible infección. Si existe deterioro general, se debe activar emergencia.
8. Si la mujer presenta infección puerperal confirmada o sospechada, se recomienda valorar también al recién nacido por posible infección relacionada y evitar manejar ambos eventos de forma independiente.
9. Si el recién nacido presenta rechazo completo o marcado del alimento, succión débil, incapacidad para sostener una toma, somnolencia que impide alimentarlo, disminución importante de las tomas, reducción de la orina, signos de deshidratación o pérdida excesiva de peso, se recomienda valoración clínica urgente.
10. Si el recién nacido presenta únicamente una técnica inadecuada de lactancia, sin deterioro, deshidratación ni pérdida preocupante de peso, se recomienda apoyo domiciliario prioritario, observación de una toma y seguimiento cercano. Si la dificultad se asocia con signos clínicos, no debe tratarse solo como un problema educativo.
11. Si el recién nacido presenta vómito bilioso, se recomienda atención urgente. El vómito repetido o proyectivo, diarrea con deshidratación, sangre en las deposiciones, ausencia de meconio durante las primeras 24 horas, deposiciones pálidas u orina oscura requieren valoración clínica.
12. Si la ictericia aparece durante las primeras 24 horas, alcanza palmas o plantas, progresa rápidamente, se asocia con somnolencia, hipotonía o mala alimentación, se acompaña de orina oscura o deposiciones pálidas o persiste más allá del periodo esperado, se recomienda remitir para medición objetiva de bilirrubina y valoración clínica.
13. Los recién nacidos prematuros, de bajo peso, con restricción del crecimiento, antecedente de reanimación u hospitalización, enfermedad congénita o metabólica, dificultades persistentes de alimentación, pérdida o ganancia insuficiente de peso, tamizajes

pendientes o tratamientos domiciliarios deben recibir seguimiento prioritario aunque no presenten signos de alarma en la visita.

14. Si la mujer presenta sangrado súbito, abundante, persistente o creciente, empapa rápidamente toallas, expulsa coágulos grandes o tejido o presenta mareo, desmayo, palidez, debilidad intensa, taquicardia, alteración del estado de conciencia o dificultad respiratoria, se recomienda activar de inmediato la emergencia obstétrica. En el hogar no se debe esperar una cuantificación exacta del volumen.
15. Si la mujer presenta cefalea intensa o persistente, alteraciones visuales, fosfenos, tinnitus, dolor epigástrico o en hipocondrio derecho, náuseas o vómitos asociados con cefalea, oliguria, disnea o presión arterial igual o mayor de 140/90 mmHg, se recomienda valoración urgente por posible trastorno hipertensivo.
16. Si la presión arterial es igual o mayor de 160/110 mmHg o la mujer presenta convulsiones, confusión, alteración del estado de conciencia o dificultad respiratoria, se recomienda activar atención inmediata. La ausencia de una medición elevada no descarta la complicación cuando existen síntomas premonitorios graves.
17. Si la mujer presenta fiebre, escalofríos, taquicardia, taquipnea, dolor uterino, abdominal, pélvico o perineal, loquios malolientes, herida con calor, secreción o apertura, síntomas urinarios con fiebre, confusión o signos de choque, se recomienda valoración urgente por posible infección puerperal o sepsis.
18. Si la mujer presenta dificultad respiratoria súbita o progresiva, dolor torácico, tos con sangre, desmayo, taquicardia asociada con disnea o dolor, o dolor, calor y edema unilateral de una pierna, se recomienda activar atención inmediata por posible tromboembolismo o compromiso cardiopulmonar. No se recomienda que la mujer se traslade sola en esta ni en ninguna situación de emergencia.
19. Si existe apertura de una herida perineal o quirúrgica, secreción maloliente, enrojecimiento que se extiende, dolor creciente o necesidad progresiva de analgésicos, se recomienda valoración clínica el mismo día. Si el dolor mamario intenso o el enrojecimiento se acompañan de fiebre o deterioro general, se debe valorar mastitis complicada o absceso.
20. Si la mujer presenta ideación, plan o intento de suicidio, pensamiento de hacer daño al recién nacido, alucinaciones, delirios, desorganización, agitación intensa, confusión o incapacidad para garantizar el cuidado, se recomienda no dejarla sola, garantizar un

adulto protector y activar de inmediato urgencias, salud mental y protección.

21. Si la EPDS presenta una respuesta positiva en el ítem de autolesión, se recomienda realizar valoración inmediata del riesgo suicida y activar la ruta según el resultado. El puntaje total no debe utilizarse para restar importancia a una respuesta positiva de seguridad.

22. Si se identifican tristeza persistente, desesperanza, ansiedad intensa, pensamientos intrusivos, dificultad de vínculo, deterioro funcional, antecedente de trastorno mental, parto traumático o bajo apoyo, sin peligro inmediato, se recomienda valoración diagnóstica, apoyo psicológico o psiquiátrico y seguimiento domiciliario prioritario.

23. Si se identifica violencia física, sexual o psicológica, amenaza contra la mujer o el recién nacido, control coercitivo que impide buscar atención, sospecha de maltrato o negligencia grave, abandono, ausencia de cuidador seguro, cuidador intoxicado o psicótico, privación deliberada de alimento o atención o temor de permanecer en el hogar, se recomienda activar la ruta de protección y, cuando exista peligro actual, una respuesta de emergencia.

    - Cuando se identifique un caso sospechoso de maltrato, negligencia o violencia contra el recién nacido o la mujer, el equipo debe:
        - ✓ Garantizar la seguridad inmediata del recién nacido y de la mujer
        - ✓ Activar la atención en salud de urgencia cuando existan lesiones o riesgo vital
        - ✓ Informar al prestador para la notificación al Sivigila (evento 875, violencia de género e intrafamiliar)
        - ✓ Reportar el caso al ICBF (Línea 141) o a la Comisaría de Familia del municipio y, si hay riesgo inminente, a la Policía (Línea 123)
        - ✓ Registrar la actuación y realizar seguimiento hasta verificar la intervención de la entidad competente.

24. La indagación sobre violencia debe realizarse, cuando sea posible, en privacidad y sin la persona potencialmente agresora. La seguridad de la mujer y del recién nacido debe prevalecer sobre la concertación ordinaria de compromisos familiares.

25. Si la mujer no cuenta con apoyo para descansar, alimentarse o acudir a controles, el cuidador no reconoce signos de alarma, existen dificultades graves para alimentar o mantener seguro al recién nacido, hay sobrecarga extrema o no existe una persona que pueda acompañar una urgencia, se recomienda aumentar la frecuencia de

visitas, considerar atención en dupla y vincular enfermería, psicología o trabajo social.

26. Si la mujer o el cuidador se encuentra intoxicado durante el cuidado, el consumo interfiere con la alimentación o vigilancia del recién nacido, se comparte cama después de consumir alcohol, sedantes u otras sustancias, existe violencia o no hay otro cuidador seguro, se recomienda activar atención clínica, salud mental y protección según la gravedad.

27. Si la pobreza, inseguridad alimentaria, falta de agua, vivienda inadecuada, ausencia de transporte, falta de afiliación o barreras administrativas impiden cuidar, alimentar o trasladar a la mujer o al recién nacido, se recomienda activar la oferta social e intersectorial, asignar un responsable y verificar el acceso. Estas condiciones no deben registrarse únicamente como incumplimiento familiar.

28. Si existe riesgo de colapso, incendio, inundación, exposición extrema a frío o calor, humo o gases tóxicos, violencia activa o ausencia total de un lugar seguro para el recién nacido, se recomienda activar una respuesta urgente y gestionar un entorno alternativo seguro.

29. Si se identifican prácticas inseguras corregibles, como superficie blanda o inclinada para dormir, almohadas u objetos sueltos, humo de tabaco, sustancias aplicadas al cordón, agua no segura o almacenamiento peligroso de medicamentos, se recomienda realizar educación y corrección inmediata, concertar un cambio concreto y verificarlo en la visita posterior.

30. Si la familia vive en una zona rural dispersa, no dispone de transporte, señal telefónica, recursos económicos o acompañante, se recomienda disminuir el umbral de remisión, anticipar el transporte, definir rutas alternas, coordinar directamente con la ESE o asegurador y aumentar la frecuencia del seguimiento.

31. Ante cualquier remisión se recomienda comunicar directamente el caso al servicio receptor, facilitar el traslado, identificar quién acompaña, confirmar la llegada, verificar que la valoración se realizó, obtener la contrarreferencia y actualizar el plan familiar. Una remisión no debe considerarse cumplida únicamente porque fue generada en el sistema.

32. Se recomienda documentar el hallazgo y hora de identificación, clasificación de urgencia, medidas iniciales, servicio activado, persona que recibió la comunicación, medio de traslado, acompañante, confirmación de llegada, resultado de la atención y plan de seguimiento.

33. Si la familia rechaza una remisión, se recomienda explorar las razones, explicar el riesgo en lenguaje comprensible, resolver barreras evitables, ofrecer alternativas seguras y documentar la decisión. Si la negativa expone al recién nacido o a una persona sin capacidad de protección a daño grave, se deben activar los procedimientos institucionales y de protección vigentes.

34. Cada equipo debe disponer de un directorio actualizado de urgencias maternas y neonatales, transporte asistencial, salud mental, atención a violencias, protección, consumo de sustancias, apoyo alimentario y social, aseguradores y programas para prematuros o recién nacidos de bajo peso. El directorio debe incluir canales disponibles fuera del horario habitual.

9.4 Pautas pregunta 4. Agencia de cuidado familiar

- En toda familia con recién nacido se recomienda comprender la agencia de cuidado como la capacidad de reconocer necesidades y riesgos, tomar decisiones informadas, organizar responsabilidades, ejecutar prácticas seguras, buscar ayuda oportunamente y movilizar recursos familiares, comunitarios e institucionales. No debe reducirse al conocimiento ni al cumplimiento pasivo de indicaciones. La agencia de cuidado debe fortalecerse en la familia como unidad y no recaer exclusivamente en la mujer; el padre, la pareja y otros cuidadores también deben desarrollar capacidades para reconocer signos de alarma, ejecutar prácticas seguras y buscar ayuda oportunamente.
- Antes de proporcionar educación se recomienda explorar qué sabe y hace la familia, qué ha funcionado, qué le preocupa, qué indicaciones ha recibido, qué desea cambiar y qué barreras o recursos tiene. El profesional debe reconocer las capacidades existentes antes de señalar los aspectos que requieren modificación.
- En cada visita se recomienda priorizar una o pocas necesidades relevantes, especialmente aquellas relacionadas con seguridad, alimentación, salud materna, salud mental o continuidad. No se recomienda formular un número excesivo de compromisos que dificulte su cumplimiento o disminuya la percepción de logro).
- La educación orientada a la agencia debe seguir una secuencia de exploración, reconocimiento de fortalezas, priorización, explicación del fundamento, demostración, práctica por parte del cuidador, retroalimentación, verificación de comprensión, concertación de una acción y seguimiento en la visita posterior.

- El hogar debe utilizarse como escenario de aprendizaje práctico. Se recomienda observar y acompañar la alimentación, preparación del espacio para dormir, cuidado del cordón, higiene de manos, mantenimiento de la temperatura, administración de tratamientos, reconocimiento de signos de alarma, preparación para el traslado y distribución del apoyo a la mujer.
- El profesional debe presentar alternativas seguras, escuchar preferencias, explicar riesgos y beneficios, reconocer el conocimiento familiar, negociar metas realistas y acompañar la toma de decisiones. No se recomienda definir unilateralmente el plan cuando existan alternativas clínicamente seguras y compatibles con las preferencias de la mujer.
- La mujer debe decidir qué personas desea vincular al plan de cuidado. La pareja, padre del bebé, familiares, amistades o vecinos pueden participar cuando constituyan apoyos seguros; no se debe promover la participación de una persona que ejerza violencia, control coercitivo o limite la autonomía.
- Cada compromiso debe ser específico, observable, viable, limitado en el tiempo y asociado con un responsable y un mecanismo de verificación. No se recomienda registrar compromisos generales como "cuidar mejor al bebé"; se deben formular acciones concretas, como preparar un espacio de sueño seguro, acompañar el control o relevar a la mujer durante un periodo definido.
- Se recomienda distribuir explícitamente las tareas: quién ejerce el cuidado principal, quién releva a la mujer, quién prepara alimentos, quién realiza tareas domésticas, quién acompaña controles, quién puede trasladar a la mujer o al recién nacido y quién apoya durante la noche. La presencia de familiares no debe asumirse automáticamente como apoyo efectivo. Se recomienda verificar que la distribución de tareas no reproduzca una sobrecarga en la mujer o en otra cuidadora y promover la participación activa del padre o la pareja en el cuidado directo del recién nacido.
- Se recomienda fortalecer el cuidado responsivo enseñando a la mujer, al padre o la pareja y a los demás cuidadores a reconocer señales de hambre, saciedad, cansancio, incomodidad y necesidad de contacto; responder al llanto de manera sensible; mantener contacto visual y verbal; sostener al bebé durante la alimentación; evitar obligarlo a terminar una toma; y prevenir prácticas bruscas o punitivas.
- Si se observa rechazo persistente hacia el recién nacido, interacción negativa, dificultad grave de vínculo o agotamiento extremo, se

recomienda realizar valoración psicosocial, explorar salud mental y aumentar la intensidad del acompañamiento.

- Se recomienda integrar apoyo emocional y solución conjunta de problemas: escuchar sin juzgar, reconocer el agotamiento, normalizar la solicitud de ayuda, identificar oportunidades de descanso, dividir problemas complejos en acciones pequeñas, anticipar dificultades y activar salud mental o apoyo social cuando corresponda.
- La agencia no debe utilizarse para trasladar a la familia la responsabilidad de resolver barreras estructurales. Si la familia comprende la recomendación, pero no cuenta con transporte, alimentos, vivienda, medicamentos, apoyo o acceso a servicios, el equipo debe movilizar recursos institucionales y comunitarios.
- Se recomienda utilizar la cartilla o programador familiar como herramienta de automonitoreo, incluyendo signos de alarma, números de contacto, próximas citas, vacunas y tamizajes, compromisos, responsables, barreras identificadas y fecha del siguiente contacto. Debe utilizar lenguaje sencillo, pictogramas o códigos comprensibles cuando sea necesario.
- Las comunicaciones remotas pueden utilizarse para reforzar acuerdos, resolver dudas, recordar citas y verificar remisiones. No deben sustituir la observación presencial cuando exista riesgo clínico, dificultad de alimentación, violencia, baja comprensión o necesidad de valorar el entorno.
- Cuando sea posible, se recomienda mantener el acompañamiento con el mismo profesional o un equipo pequeño de referencia. Cada visita debe retomar los hallazgos, compromisos y rutas previas, evitar recomendaciones contradictorias y actualizar el plan según la evolución.
- En la primera visita se recomienda comprender la situación, observar el hogar, identificar fortalezas y riesgos, priorizar necesidades, realizar enseñanza práctica, concertar compromisos y programar el seguimiento. En la segunda visita se recomienda revisar los compromisos, observar nuevamente las prácticas, resolver barreras y confirmar controles y remisiones. En visitas posteriores se recomienda consolidar las prácticas y transferir progresivamente mayor control a la familia.
- El cierre del ciclo no debe depender exclusivamente del número de visitas realizadas. Se recomienda cerrarlo o transitar al seguimiento ordinario cuando no existan riesgos activos sin manejo, las rutas se hayan cumplido, la familia demuestre capacidades suficientes, las

prácticas prioritarias sean sostenidas y exista una red de apoyo disponible.

- Se recomienda aumentar la frecuencia y, cuando corresponda, utilizar visita en dupla en familias con dificultades de alimentación, prematuridad, bajo peso, depresión, ansiedad, violencia, escaso apoyo, baja capacidad de cuidado o barreras importantes de acceso. La intensidad puede reducirse gradualmente cuando exista estabilidad y mayor autonomía.
- Para monitorear la fidelidad de la intervención se recomienda registrar si la visita fue oportuna; si se valoró a la mujer, el recién nacido y la familia; si participaron el padre, la pareja u otros cuidadores y la red elegida; si se identificaron necesidades educativas; si se realizó demostración y práctica; si se verificó comprensión; si se concertaron compromisos; y si se programó y realizó el seguimiento.
- La falta de transporte, tiempo, personal, equipos, materiales, conectividad o capacidad de respuesta debe registrarse como una barrera del programa y no como incumplimiento de la familia.
- Para monitorear las capacidades familiares se recomienda verificar si la familia puede explicar los signos de alarma, indicar dónde consultar, demostrar alimentación segura, preparar un espacio de sueño seguro, cuidar el cordón, reconocer señales de hambre y saciedad, describir el autocuidado materno, identificar un relevo y utilizar la cartilla familiar, verificando que estas capacidades estén presentes no solo en la mujer, sino también en el padre, la pareja u otros cuidadores que participan en el cuidado.
- Las escalas de autoeficacia, competencia parental o preparación pueden utilizarse como complemento cuando sean pertinentes, pero no deben sustituir la demostración práctica. No se identificó una medida única validada para valorar integralmente la agencia de cuidado familiar en hogares con recién nacidos.
- Para monitorear cambios en prácticas se recomienda observar y comparar con la línea de base la alimentación, postura y agarre, seguridad del sueño, cuidado del cordón, higiene de manos, uso de medicamentos, asistencia a controles, vacunación, tamizajes, exposición al humo, apoyo a la recuperación materna y distribución del cuidado.
- En cada visita se recomienda clasificar los compromisos como cumplidos y sostenidos, parcialmente cumplidos, iniciados, no iniciados, suspendidos, no aplicables, no cumplidos por barrera familiar

o no cumplidos por barrera del sistema. Esta clasificación permite ajustar el plan sin culpabilizar a la familia.

- Si un compromiso no se cumple, se recomienda explorar qué ocurrió, identificar la barrera, revisar si continúa siendo pertinente, simplificarlo o dividirlo, modificar el responsable, movilizar apoyos, establecer un nuevo plazo y aumentar la frecuencia del seguimiento si persiste un riesgo.
- La semaforización del PICF puede utilizarse para representar el avance de los compromisos, pero debe interpretarse como una herramienta operativa y no como una escala validada de resultados maternos, neonatales o familiares. No debe utilizarse para responsabilizar a la familia por barreras del sistema o determinantes sociales.
- Se recomienda monitorear resultados clínicos y de continuidad, incluyendo alimentación segura, evolución adecuada del peso, resolución de dificultades de alimentación, control de puerperio y del recién nacido, vacunas y tamizajes, consulta oportuna ante signos de alarma, tratamiento de salud mental, reducción de riesgos del hogar, remisiones cumplidas y continuidad después de urgencias u hospitalizaciones.
- Se recomienda monitorear la experiencia, autonomía y seguridad de la mujer y la familia, preguntando si fueron escuchadas, participaron en las decisiones, comprendieron la información, pudieron expresar dudas, consideraron pertinentes las recomendaciones, consintieron la participación de la familia y percibieron respeto y privacidad durante la visita.
- Una intervención no debe considerarse exitosa si consigue una conducta mediante presión, miedo, culpabilización o pérdida de autonomía. La experiencia de la mujer debe formar parte de la evaluación de aceptabilidad y calidad.
- Se recomienda analizar la cobertura, oportunidad y resultados según municipio, ruralidad, subred y nivel de riesgo, incluyendo visitas no realizadas y su causa, tiempo de desplazamiento, transporte, perfiles profesionales disponibles, continuidad del equipo, conectividad, disponibilidad de equipos, remisiones fallidas y necesidades sociales sin respuesta.
- El monitoreo del PICF no debe limitarse al número de visitas o compromisos registrados; debe establecer qué componentes fueron entregados, qué habilidades fueron demostradas, qué prácticas cambiaron, qué barreras persisten y qué resultados clínicos, familiares y de continuidad se alcanzaron.

10. Referencias

1. Secretaria de salud de Boyacá. Análisis de la sitación de salud de la vigencia 2023. ASIS Boyacá 2023. Tunja; 2024.
2. Secretaria de Salud de Boyacá. Análisis de la situación de salud de la vigencia 2024. ASIS Boyacá 2024. Tunja; 2025.
3. Secretaria de Salud de Boyacá. Informe trimestral de indicadores SIBACOM. Tunja; 2025 Jul.
4. World Health Organization - WHO. WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience. World Health Organization; 2022. 242 p.
5. Ministerio de Salud y Protección Social. Lineamiento técnico y operativo de la Ruta Integral de Atención en Salud Materno Perinatal. RIA Materno-Perinatal. Bogotá D.C.; 2018 Jul.
6. Institute for Health N, Excellence C. Postnatal care NICE guideline [Internet]. 2021. Available from: www.nice.org.uk/guidance/ng194
7. Moutwakil A, Kumar A, Li AT, Huang CJ, Nelson BD, Woodward A, et al. Implementation of essential newborn care in settings of high-intensity armed conflict: a systematic review. BMJ Glob Health. 2026 Mar 1;11(3). doi:10.1136/bmjgh-2025-018964
8. Moyer VA. Primary Care Interventions to Prevent Child Maltreatment: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med [Internet]. 2013;(159):289–95. Available from: www.annals.org
9. NICE. Jaundice in newborn babies under 28 days Clinical guideline [Internet]. 2023. Available from: www.nice.org.uk/guidance/cg98
10. Nicholson WK, Silverstein M, Wong JB, Chelmow D, Coker TR, Davis EM, et al. Primary Care Behavioral Counseling Interventions to Support Breastfeeding: US Preventive Services Task Force Recommendation Statement. JAMA. American Medical Association; 2025. p. 1520–6. doi:10.1001/jama.2025.3650 PubMed PMID: 40198087.
11. Secretaria de Salud de Boyacá. LINEAMIENTO TÉCNICO PICF 2025. 2025.
12. McDonald SD, Narvey M, Ehman W, Jain V, Cassell K. Guideline No. 424: Umbilical Cord Management in Preterm and Term Infants.

Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada. 2022 Mar 1;44(3):313-322.e1. doi:10.1016/j.jogc.2022.01.007 PubMed PMID: 35300830.

13. Kocakabak C, van den Hoogen A, Rothfus M, Campbell-Yeo M, Kostenzer J, Axelin A, et al. Identifying outcomes and outcome measures in neonatal family-centered care trials: a systematic review. Pediatric Research. Springer Nature; 2025. p. 56–66. doi:10.1038/s41390-024-03293-2 PubMed PMID: 38849484.

11. Anexos

11.1 Anexo 1. Ecuaciones de búsqueda

Pregunta orientadora	Tipo de pregunta	Estructura PICO/PIRD	Términos clave	Ecuación de búsqueda
En familias con recién nacidos en el entorno hogar, ¿qué estrategias, instrumentos o criterios de valoración integral utilizados por los equipos de salud permiten identificar y estratificar el riesgo materno, neonatal, familiar, psicosocial y del entorno, para orientar la priorización del seguimiento, las acciones de cuidado y la activación oportuna de rutas de atención?	Evaluación / clasificación de riesgo	P: familias con recién nacido y/o mujer en posparto en entorno hogar; recién nacidos, madres posparto y cuidadores. I: estrategias o instrumentos de valoración y estratificación del riesgo individual y familiar. C: otra herramienta, valoración usual o ausencia de instrumento. O: identificación oportuna de riesgos neonatales, maternos, familiares, psicosociales, ambientales y de cuidado; apoyo a decisiones en nivel primario.	newborn, neonate, postpartum women, puerperium, family, home visit, home care, primary health care, risk assessment, screening, family assessment, maternal risk, neonatal risk, breastfeeding, caregiver, family functioning, social support	Subpoblacion neonatos: En recién nacidos atendidos en el entorno hogar, ¿qué guías, recomendaciones, instrumentos o criterios permiten valorar y estratificar el riesgo neonatal para orientar el seguimiento, la educación familiar, la remisión y la activación oportuna de rutas de atención?
En familias con recién nacidos y mujeres en posparto atendidas en el entorno hogar, ¿qué	Intervención / efectividad / implementación	P: familias con recién nacido y mujeres en posparto en entorno hogar. I: intervenciones	postnatal home visits, family-based intervention, breastfeeding support,	("Infant, Newborn" OR newborn* OR neonat* OR "recién nacido") AND ("Postpartum Period" OR

intervenciones familiares estructuradas son efectivas y factibles para mejorar resultados de salud neonatal, materna-posparto y de cuidado familiar, y qué componentes deben estandarizarse en el PICF?		familiares domiciliarias o basadas en el hogar. C: atención usual, no intervención u otra intervención. O: lactancia, vínculo, cuidado neonatal seguro, salud mental materna, detección de complicaciones, uso oportuno de servicios, factibilidad y estandarización.	newborn care, maternal care, parenting support, postpartum support, depression prevention, kangaroo care, early stimulation, implementation, standardization	postpartum OR postnatal OR puerper* OR posparto) AND (family-based OR family OR caregiver* OR household OR home OR "entorno hogar") AND ("home visit*" OR "home care services" OR intervention* OR program* OR counseling OR education OR "breastfeeding support" OR "newborn care" OR "parenting support" OR "postpartum support") AND (effectiveness OR efficacy OR implementation OR feasibility OR standardization OR protocol*) AND (guideline* OR "systematic review" OR meta-analysis OR consensus)
En recién nacidos, mujeres en posparto y familias atendidas en el entorno hogar, ¿qué signos de alarma y criterios de riesgo clínico, psicosocial, familiar o del entorno deben activar rutas de atención, remisión,	Detección / seguridad / referencia	P: familias con recién nacido y/o mujer en posparto atendidas en entorno hogar o nivel primario. I: criterios de alarma, signos de peligro y activación de rutas/remisión. C: ausencia de criterios explícitos o manejo	danger signs, warning signs, neonatal danger signs, postpartum warning signs, referral criteria, care pathway, continuity of care, maternal complications, neonatal	("Infant, Newborn" OR newborn* OR neonat* OR "recién nacido") AND ("Postpartum Period" OR postpartum OR puerper* OR posparto) AND (family OR familia* OR home OR household OR "entorno hogar") AND ("danger signs" OR "warning signs"

seguimiento prioritario o respuesta intersectorial para garantizar oportunidad y continuidad del cuidado en el nivel primario?		habitual. O: detección oportuna, remisión adecuada, continuidad del cuidado, menor complicación materna o neonatal, menor hospitalización evitable.	complications, primary health care	OR "red flags" OR "neonatal danger signs" OR "postpartum warning signs" OR referral OR "care pathway" OR "care escalation" OR triage) AND ("Primary Health Care" OR "primary care" OR continuity OR "continuity of patient care") AND (guideline* OR "systematic review" OR protocol* OR consensus)
En familias con recién nacidos y mujeres en posparto atendidas mediante visitas sucesivas en el entorno hogar, ¿qué estrategias educativas, participativas y de seguimiento favorecen la agencia de cuidado familiar, y cómo debe monitorearse su implementación durante el ciclo de cuidado del PICF?	Organización del cuidado / seguimiento / implementación	P: familias con recién nacido y mujeres en posparto en entorno hogar. I: estrategias para fortalecer agencia de cuidado, educación dialógica, seguimiento familiar, monitoreo en visitas sucesivas, articulación con redes. C: seguimiento habitual o no estructurado. O: capacidades familiares de cuidado, adherencia, autocuidado materno, participación del cuidador/familia, continuidad, monitoreo de logros.	family agency, caregiving capacity, postpartum self-care, family empowerment, home visits, follow-up, monitoring, continuity of care, family education, social support, community networks	("Postpartum Period" OR postpartum OR postnatal OR puerper* OR posparto) AND ("Infant, Newborn" OR newborn* OR neonat* OR "recién nacido") AND (family OR familia* OR caregiver* OR household OR home OR "entorno hogar") AND ("family empowerment" OR "caregiving capacity" OR "self-care" OR education OR counseling OR follow-up OR monitoring OR "continuity of patient care" OR "social support" OR "community network*") AND (implementation OR feasibility OR adherence OR outcomes) AND (guideline* OR

				"systematic review" OR consensus OR "best practice")